

TEMA 32



LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MADRID, MADRID SALUD:

COMPETENCIAS, RED DE CENTROS Y SERVICIOS QUE SE PRESTAN.

PAPEL DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL EN LAS INTERVENCIONES DE SALUD COMUNITARIA.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Marco legislativo en materia de Salud Pública.	
1.1.- Legislación estatal. 1.2.- Legislación autonómica.	
2.- Madrid Salud: competencias, red de Centros y Servicios que se prestan.	
2.1.- Estructura organizativa del Organismo Autónomo "Madrid Salud". 2.2.- Actuaciones en materia de Salubridad Pública. 2.3.- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 2.4.- Prevención de riesgos laborales.	
3.- Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud: Madrid, una ciudad saludable, 2.021-2.024.	
3.1.- Misión y visión de la Estrategia Madrid, Ciudad Saludable. 3.2.- Principios rectores y criterios metodológicos. 3.3.- Objetivos generales y objetivos operativos. 3.4.- Líneas de actuación. 3.5.- Marco operativo.	
4.- Papel del/la trabajador/a social en las intervenciones en Salud Comunitaria.	
4.1.- El Trabajo Social Sanitario. 4.2.- El papel del/la trabajador/a social en el ámbito de la salud.	

O.- INTRODUCCIÓN.

La **salud pública** es una parte de la ciencia médica de carácter multidisciplinario, cuyo objeto primordial es la formación actualizada de todo profesional de la salud, que obtiene, depende y colabora con los conocimientos a partir de todas las ciencias (Sociales, Biológicas y Conductuales), y sus diferentes protocolos de investigación, siendo su actividad eminentemente social, cuyo objetivo es ejercer y mantener la salud de la población, así como de control o erradicación de la enfermedad.

Las funciones esenciales de la salud pública son:

1. Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud.
2. Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública.
3. Promoción de la salud.
4. Participación de los ciudadanos en la salud.
5. Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación, y gestión en materia de salud pública.
6. Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación, y fiscalización en materia de salud pública.
7. Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios.
8. Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública.
9. Garantía y mejora de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos.
10. Investigación en salud pública.
11. Reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud.

Podemos destacar algunos conceptos importantes:

. Protección sanitaria: Son actividades de salud pública dirigidas al control sanitario del medio ambiente en su sentido más amplio, con el control de la contaminación del suelo, agua, aire y de los alimentos y recursos. Además, se incluye la detección de factores de riesgo para la población y la elaboración de programas de salud para la sociedad. Pretende dar alternativas de solución a enfermedades que implican a cualquier población.

. Promoción sanitaria: Son actividades que intentan fomentar la salud de los individuos y colectividades, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables, mediante intervenciones de educación sanitaria a través de medios de comunicación de masas, en las escuelas y en atención primaria. La educación sanitaria debe ser complementada con los cambios necesarios en el medio ambiente y en las condiciones sociales y económicas que permitan a los ciudadanos el ejercicio efectivo de los estilos de vida saludables y la participación en la toma de decisiones que afecten a su salud.

. Prevención epidemiopatológica: Se basa en intervenciones de prevención primaria (vacunaciones), prevención secundaria o detección precoz de enfermedades y de prevención terciaria o de contención y/o rehabilitación de la secuelas dejadas por el o los daños de las funciones físicas, psíquicas y/o sociales. que debe ser así para todos.

Es importante hacer referencia al concepto de **determinantes de la salud.** Podemos considerar como factores determinantes de la salud:

1. **Estilo de vida**: Es el determinante que más influye en la salud y el más modificable mediante actividades de promoción de la salud o prevención primaria.
2. **Biología humana**: Este determinante se refiere a la herencia genética que no suele ser modificable actualmente con la tecnología médica disponible.
3. **Sistema sanitario**: Es el determinante de salud que quizá menos influya en la salud y sin embargo es el determinante de salud que más recursos económicos recibe para cuidar la salud de la población, al menos en los países desarrollados.
4. **Medio ambiente**: Contaminación del aire, del agua, del suelo y del medio ambiente psicosocial y sociocultural por factores de naturaleza:
    1. Biológica (bacterias, virus, hongos, etc.)
    2. Física (radiaciones, humos, desechos, etc.)
    3. Química (hidrocarburos, plomo, plaguicidas, etc.)
    4. Psicosocial y sociocultural (dependencias, violencias, estrés, competitividad, etc.)

Los requisitos para la salud descritos en la **carta de Ottawa** (1.986) son: la paz, la educación, el vestido, la comida, la vivienda, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Este documento de Naciones Unidas considera que la **promoción de la salud** es una **estrategia fundamental para aumentar la salud de la población**, concibiéndose como un proceso global que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla.

La **estrategia Salud 21** es la respuesta de la **Región Europea de la OMS** a la política global de salud para todos. Su objetivo principal y permanente es **conseguir que todas las personas alcancen plenamente su potencial de salud:** sus metas son **promover y proteger la salud de las personas a lo largo de toda su vida y reducir la incidencia de las principales enfermedades y lesiones, así como el sufrimiento que originan**.

Los **fundamentos éticos de Salud 21** son: 1. La salud como derecho fundamental de los seres humanos; 2. la equidad en materia de salud y la solidaridad de acción en todos los países, dentro de ellos y entre sus habitantes, y 3. la participación y la responsabilidad de las personas, los grupos, las instituciones y las comunidades en el desarrollo continuo de la salud.

A partir de la información obtenida sobre el grado de aplicación de la estrategia Salud Para Todos (SPT) en la Región Europea desde los años 80, la OMS recomienda una lista de objetivos que sirvan de inspiración para que cada país formule los propios. Los objetivos regionales tratan de ser realistas y factibles, pero no normativos, ya que no son igualmente aplicables a todos los países de la Región Europea, de manera que cada país debe ajustar los objetivos a las políticas de salud según sus propias circunstancias.

1.- MARCO LEGISLATIVO EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

1.1.- LEGISLACIÓN ESTATAL.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

Podemos señalar tres referencias en la Constitución Española en relación al **derecho a la salud.**

Art. 43	1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.
Art. 148.1.21	Es competencia exclusiva de las CC.AA.: - La sanidad e higiene.
Art. 149.1.16	Es competencia exclusiva del Estado: - La sanidad exterior, las bases y la coordinación sanitaria y la legislación farmacéutica.

LEY 7/1.985, REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL.

La **Ley 7/1.985** establece en el art. **25.2.** las competencias de la Administración Local. En este sentido, destacamos:

El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

j) Protección de la salubridad pública.

k) Cementerios y actividades funerarias.

LEY GENERAL DE SANIDAD 14/1.986.

Esta Ley supone el desarrollo normativo del derecho a la protección de la salud reconocido en el art. 43 de la Constitución.

Los beneficiarios del sistema de salud son:

- Todos los españoles y ciudadanos extranjeros con permiso de residencia.
- En relación a los extranjeros no residentes y a los españoles que se encuentren fuera del país, lo que establezcan las Leyes y los Convenios Internacionales.

El **Sistema Nacional de Salud** es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.

En la línea de la **Declaración de Alma-Ata** (1.978) se consideran como acciones relacionadas con la protección a la salud la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la superación de las desigualdades en salud, la universalización de la asistencia sanitaria y la participación de la comunidad.

La atención sanitaria se articula en:

- Atención primaria.
- Atención especializada.
- Atención farmacéutica.

De esta forma se garantiza una atención integral que incluya promoción, prevención, curación y rehabilitación.

1.2.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (L.O. 3/1.983).

Las competencias sanitarias de la Comunidad de Madrid vienen establecidas en el **art. 27**, es decir, competencias que se ejercen "en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución".

Y de forma específica, se establecen como competencias en los arts. **27.4 y 27.5**:

4. Sanidad e higiene.

5. Coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social.

Real Decreto 1.479/2.001, de traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Insalud.

Las funciones y servicios del Insalud son asumidas por la Comunidad de Madrid.

LEY 12/2.001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El **Título VI de la Ley 12/2.001** desarrolla en su articulado las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de salud pública.

Las competencias de la Comunidad de Madrid en este ámbito (actualmente son asumidas desde la **Dirección General de Salud Pública** de la **Consejería de Sanidad** son):

La **función de Autoridad en Salud Pública** incluye:

a) La adopción cuando proceda, de las medidas previstas en la Ley 3/1986, de 14 de abril de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y especialmente en los supuestos contemplados en sus artículos 2 y 3.

b) La adopción de cualquier otra medida necesaria en función del análisis de los determinantes del proceso salud-enfermedad en la Comunidad de Madrid.

c) La función de inspección en salud pública incluyendo el control sanitario y la prevención de los riesgos para la salud en la cadena alimentaria desde la producción hasta su comercialización y cualquier otra actuación relacionada con la inspección territorial de salud pública.

d) Las actuaciones relacionadas con la aplicación de la legislación vigente en materia de sanidad mortuoria, en evitación de los riesgos derivados de las prácticas tanatológicas, incluyendo las condiciones sanitarias de los cementerios, velatorios y demás establecimientos relacionados con el manejo de cadáveres.

e) El desarrollo en materia de salud pública de las competencias determinadas por el artículo 28.2 de la Ley 3/1983 de 25 de febrero del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a la administración, ejecución, inspección y dictado de reglamentos de carácter interno de organización de los servicios correspondientes, de conformidad con las normas reglamentarias de carácter general que, en desarrollo de su legislación, dicte el Estado.

f) La propuesta de normas, contratos y convenios que en el marco de la legislación de superior rango interesen para garantizar la mejora de la salud de la población de la Comunidad de Madrid, el dictado de resoluciones con las que articular los procedimientos administrativos tendentes a garantizar la ejecución de las funciones de salud pública, y la propuesta de los programas y acciones y del contenido económico para financiarlos, que haya de ser recogido en las leyes de presupuestos correspondientes a cada ejercicio.

2. La **elaboración del Informe del Estado de Salud** de la Población de la Comunidad de Madrid.

3. La **promoción de la salud** como actividad fundamental del Sistema.

4. La promoción del interés individual, familiar y social por la salud mediante la **educación sanitaria de la población**, y de promoción de la educación para la salud, como método, en la relación profesional sanitario-paciente.

5. La **promoción de la vigilancia epidemiológica** tanto de las enfermedades transmisibles como no transmisibles, y de todos los determinantes del proceso salud-enfermedad relacionados con la interacción del individuo con el medio. A tal fin, y con sujeción a lo establecido en la norma estatal y autonómica aplicable a la materia de protección de datos de carácter personal, los datos relativos a la salud serán cedidos a la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid por parte de los responsables de los ficheros, cualquiera que sea su titularidad, cuando resulten necesarios para prevención de la enfermedad, o la realización de estudios epidemiológicos.

6. La **aprobación de los programas de prevención de enfermedades** elaborados por el Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, o por cualquier otro centro o servicio público del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

7. La **Veterinaria de Salud Pública** en relación con el control de la higiene, la tecnología y la seguridad alimentaria, así como la prevención y lucha contra las zoonosis y las técnicas necesarias para la evitación de riesgos en el hombre, debidos a la vida animal o sus enfermedades.

8. La **adecuación del medio ambiente** a la salud en todos los ámbitos de la vida.

9. La **promoción y mejora de la salud laboral**.

10. La **promoción de la mejora de la formación del personal** al servicio de la organización sanitaria, y de fomento de la investigación científica en el campo específico de los problemas de salud pública, mediante su participación en las actividades de la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid.

11. La **colaboración con el sector privado de servicios de salud** que desarrolle programas o actividades de prevención primaria o secundaria, a fin de establecer objetivos comunes y definir en que modo la información de salud o morbilidad obtenida en dichos programas se incorpora a los sistemas de registro que con carácter general desarrolle el sistema público para el mismo fin.

En su **art. 18** la LOSCAM recoge que:

1. Las **Corporaciones Locales** de la Comunidad de Madrid, en los términos previstos en la presente Ley, ejercerán las competencias que en **materia de control sanitario y salubridad** les atribuye el Ordenamiento Jurídico, sin perjuicio de su capacidad institucional de actuación complementaria, y de desarrollo de las competencias que en su caso les delegue la Comunidad.

En el **art. 137** se enumeran las siguientes **competencias:**

1. Las corporaciones locales ejercerán las competencias en materia sanitaria que tienen atribuidas en la legislación de régimen local. No obstante, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones Públicas, tendrán las siguientes responsabilidades en relación con el obligado cumplimiento de las normas y los planes sanitarios:

a) Prestar los servicios mínimos obligatorios, establecidos en la legislación que regula el régimen municipal en lo referente a los servicios de salud y los regulados en la presente Ley.

b) **Control sanitario del medio ambiente**: Contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones, abastecimiento y saneamiento de aguas, residuos urbanos e industriales.

c) **Control sanitario de industrias, actividades, servicios y transportes**.

d) **Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana**, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas y campamentos turísticos y áreas de actividad física, deportiva y de recreo.

e) **Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas** y demás productos relacionados con el uso o consumo humano, así como los medios de su transporte.

f) **Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria**.

g) **Desarrollo de programas de promoción de la salud, educación sanitaria y protección de grupos sociales con riesgos específicos,** coherentes con los objetivos del Informe del Estado de Salud de la Población de la Comunidad de Madrid y resto de prescripciones establecidas en la presente Ley.

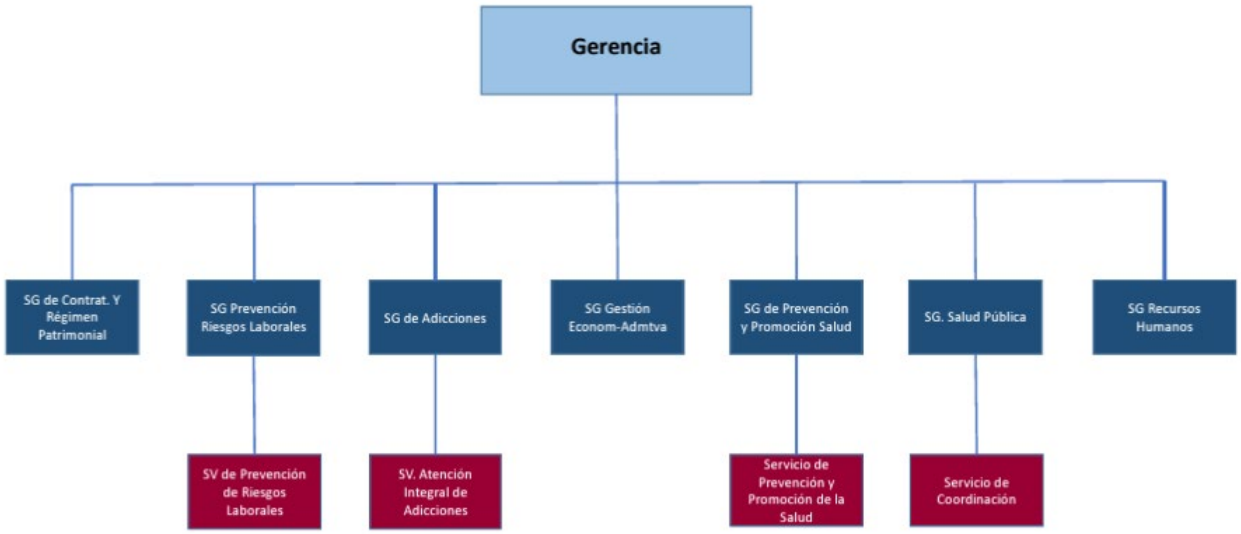
h) Realizar actividades complementarias de las que sean propias de otras Administraciones públicas en las materias objeto de la presente Ley, y en particular, respecto a la **educación sanitaria, vivienda, protección del medio y fomento del deporte** en los términos establecidos en la legislación que regula el régimen municipal.

2.- MADRID SALUD: COMPETENCIAS, RED DE CENTROS Y SERVICIOS QUE SE PRESTAN.

2.1.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "MADRID SALUD".

El **19 de noviembre de 2.004** el Ayuntamiento de Madrid aprueba los **Estatutos del Organismo Autónomo Madrid Salud**, que actualmente se sitúa dentro del **Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias.**

Se trata de un Organismo Autónomo, dotado de personalidad jurídica propia diferenciada, patrimonio propio y autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines. Su finalidad es la **gestión de la política municipal en las materias de Salud Pública y Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, en el término municipal de Madrid.**



Salud Pública.	Se engloban las actuaciones municipales referentes a promoción de la salud, prevención de enfermedades, calidad y seguridad alimentaria, salud ambiental, control zoosanitario, sanidad mortuoria, evaluación de las actuaciones, inspección sanitaria, la formación e investigación en estos ámbitos y cuantas otras actuaciones puedan corresponder al organismo para la consecución de sus fines.
Drogodependencias y otros trastornos adictivos.	Se engloban las actuaciones municipales referentes a asistencia, prevención, reinserción y evaluación en el campo de las adicciones, la formación e investigación en estos ámbitos y cuantas otras actuaciones puedan corresponder al organismo para la consecución de sus fines.

De acuerdo con sus Estatutos, son **competencias** de Madrid Salud, las siguientes:

- Planificación, dirección, gestión, supervisión, coordinación y evaluación de las actuaciones en el ámbito municipal relativas a la **Salud Pública y a las Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.**
- Dirección, gestión, supervisión y evaluación de las **actividades preventivas, sanitarias y asistenciales** de los centros y establecimientos sanitarios de competencia municipal.
- **Prevención y promoción de la salud y de los hábitos saludables** en la población del municipio.
- **Dirección y supervisión de la Inspección Sanitaria de las Juntas Municipales de Distrito**, impartiendo directrices a través de los servicios competentes del Área de Coordinación Territorial. Se incluyen las actuaciones preventivas y de Policía Sanitaria, así como las actuaciones urgentes en casos de crisis y emergencia en Salud Pública, que afecten a la seguridad de consumidores y usuarios, coordinando la red alimentaria en el Municipio de Madrid.
- **Elaboración del Plan Anual de Inspección** en colaboración con las Juntas de Distrito y el Área de Coordinación Territorial en el que se plasmarán los modos, procedimientos y líneas generales de actuación de la Inspección en materia de Salud Pública para la ciudad de Madrid, así como la supervisión y evaluación de las mismas.
- Informar, conjuntamente con el Área de Coordinación Territorial, todas las **actuaciones que en materia de Salud Pública se plantee realizar desde las Juntas de Distrito.**

- Planificación, dirección, gestión, supervisión y evaluación de las actuaciones encaminadas a garantizar la **calidad y seguridad alimentaria** en el Municipio.
- **Inspección de los establecimientos y empresas cuya actividad pueda incidir en la seguridad alimentaria y/o salud ambiental**, como apoyo o complementación a las funciones inspectoras que en estas materias tienen encomendadas las Juntas Municipales de Distrito.
- **Información, formación, apoyo y asesoramiento** en materia de Salud Pública y de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, tanto a usuarios y pacientes, como a asociaciones, pacientes y sus familias, y entidades públicas o privadas.
- **Formación en materias de Salud Pública, Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos** a entidades y profesionales públicos o privados, incluido personal municipal, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos del Ayuntamiento de Madrid, así como la acreditación de dicha formación.
- **Información, asesoramiento, solicitud de informes y, en su caso, prestación de auxilio a las Juntas de Distrito** a través del Área de Coordinación Territorial, y a otros órganos municipales en materias de Salud Pública, Sanidad, Higiene Alimentaria y Salud Ambiental, asi como en Drogodepdencias y otros Trastornos Adictivos.
- **El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de Salud Pública en general** y de control de tallas de los productos de pesca en la empresa mixta Mercamadrid.
- Control de la **sanidad mortuaria**, así como gestión, dirección e inspección de los aspectos sanitarios vinculados a las actividades relacionadas con los servicios funerarios de competencia municipal.
- **Control zoosanitario** que incluye la elaboración y censo de animales de compañía, realización de campañas de identificación y vacunación obligatorias, aplicación de medidas de control de animales vagabundos y agresores y otras actuaciones frente a focos zoonópticos o epizoonoticos.
- **Vigilancia en la Salud Pública.**
- **Planificación, gestión y evaluación de los programas y actividades de salud ambiental**, con especial atención a las patologías emergentes, y sin perjuicio de las actividades de gestión al respecto que realicen las Juntas de Distrito.
- **Dirección, gestión, control y evaluación de todos los recursos públicos relativos a Salud Publica**, así como las **actividades preventivas, asistenciales e integradoras de los Centros y establecimientos sanitarios de competencia municipal**, tanto las dirigidas a pacientes afectos de una adicción y a sus familias como a la población en general, coordinando sus actuaciones según las directrices establecidas.
- Planificación, programación, control y evaluación de las actuaciones de la **Escuela de Salud Pública.**
- Dirección, gestión y evaluación del **Laboratorio de Salud Pública.**
- Dirección, coordinación y evaluación de la **Inspección Sanitaria de la Empresa de economía mixta Mercamadrid**, así como las actuaciones de inspección encaminadas al control de las tallas de los productos de la pesca que en ella se comercialicen.
- **Dirección de la Oficina de Salud para Madrid** en coordinación con las redes locales, autonómica, nacional y europea de Ciudades Saludables, así como con la Organización Municipal de la Salud.
- **Dirección, gestión, supervisión, evaluación y control de los recursos municipales de asistencia y/o reinserción de pacientes drogodependientes**, así como de las actividades de prevención de las adicciones o del consumo de sustancias de abuso.
- **El ejercicio**, en el Municipio de Madrid, de las competencias atribuidas por el art. 45.2. de la **Ley 5/2.002**, de 27 de junio, de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos a las Corporaciones Locales.

- **Coordinación, en materias de Salud Pública y de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos**, de aquellas actuaciones, programas y dispositivos de **titularidad privada** que reciban fondos públicos municipales y/o actúen en el Municipio.
- **Estudio, análisis y sistematización de toda la información** que, en materias de Salud Pública y de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos se produzca dentro del municipio de Madrid.
- **Elaboración y firma de Convenios** con Instituciones Públicas y Privadas en materias de Salud Pública y de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.
- **Concesión de subvenciones** en materia de Salud Pública y Drogodependencias.
- **Organización de eventos y otras actividades** informativas, científicas, técnicas o culturales en materia de Salud Pública y de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.
- **Coordinación y relaciones institucionales** en representación del Ayuntamiento de Madrid con los Organismos e Instituciones competentes en materias de Salud Pública y de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos a nivel local, autonómico, nacional e internacional.
- **Dirección, gestión y evaluación de las actividades municipales en materia de Protección Animal, Animales potencialmente peligrosos** y otras competencias que en este ámbito otorgue al Ayuntamiento de Madrid la normativa aplicable en colaboración con el Área de Coordinación Territorial en lo que a las Juntas de Distrito se refiera.
- **El ejercicio de la potestad sancionadora** prevista en la Ley 1/90 de 1 de febrero de **Protección de los Animales Domésticos** y en la Ley 50/99 de 23 de diciembre de **Régimen Jurídico de la Tenencia de animales potencialmente peligrosos**, sin perjuicio de las competencias delegadas en los Presidentes de las Juntas Municipales de Distrito.
- **Planificación y organización de programas de divulgación y participación ciudadanas en materia de protección y bienestar animal.**
- Planificación, dirección y supervisión de la **Inspección Municipal en materia de animales de compañía**, a través del Área de Coordinación Terrirorial en lo que a las Juntas de Distrito se refiera.
- Planificación, dirección, gestión, supervisión y evaluación en materia de **control de otras poblaciones animales que puedan constituir riesgo para la salud y seguridad** por su potencialidad como plaga, capacidad vectorial u otras.

El Organismo Autónomo "Madrid Salud" se compone de dos Institutos Municipales, ambos con rango de Subdirección General:

- El **Instituto de Salud Pública.**
- El **Instituto de Adicciones.**

También dependen de "Madrid Salud" el **Laboratorio de Salud Pública** y la **Escuela de Salud Pública.**

Desde el Organismo Autónomo "Madrid Salud" se han aprobado diversas Cartas de Servicios en materia de salud pública, entre ellas podemos destacar:

- **Carta de Servicios de la Calidad del Agua de consumo en grifo** (aprobada el 15 de noviembre de 2.018).
- **Carta de Servicios de Habitabilidad y Salubridad de la vivienda** (aprobada el 7 de julio de 2.011).
- **Carta de Servicios de las Actuaciones urgentes ante brotes y alertas alimentarias** (aprobada el 22 de julio de 2.010).

- **Carta de Servicios de Prevención y control de plagas** (aprobada el 20 de febrero de 2.014).
- **Carta de Servicios de Salud Laboral** (aprobada el 19 de mayo de 2.011).
- **Carta de Servicios del Centro de prevención del deterioro cognitivo** (aprobada el 24 de noviembre de 2.016).
- **Carta de Servicios del Consejo Sanitario en Viajes y Vacunación Internacional** (aprobada el 29 de abril de 2.015).
- **Carta de Servicios del Instituto de Adicciones** (aprobada el 8 de febrero de 2.007).
- **Carta de Servicios del Laboratorio Municipal de Salud Pública** (aprobada el 22 de septiembre de 2.022).

2.2.- ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA.

Las actividades que desarrolla Madrid Salud a través de la Subdirección General de Salud Pública y de la Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud se pueden encuadrar en el concepto de la "**protección de la salubridad pública**", como son la seguridad alimentaria, la salud ambiental, la promoción de la salud y bienestar animal, el control de plagas y las actividades de inspección y control oficial, incluida la toma de muestras y su análisis a través del Laboratorio de Salud Pública. Así como el desarrollo de programas y actividades de promoción de la salud con un enfoque grupal y comunitario.

Seguridad Alimentaria.	En materia de Seguridad Alimentaria, Madrid Salud tiene atribuidas los siguientes cometidos: • Establecer las directrices y ejercer la supervisión de la inspección de las actividades objeto de control sanitario realizada por los Distritos, así como adoptar medidas provisionales, incluido el decomiso y ratificar, modificar o levantar las acordadas por los servicios de inspección de Madrid Salud. • Auditar los servicios de inspección sanitaria de los Distritos, con el fin de verificar que los actos, operaciones y procedimientos de inspección se han desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que sean de aplicación. • Administrar un sistema de información único que recoja todas las actuaciones en materia de salud pública, realizadas por los Distritos como por Madrid Salud Estas competencias se desarrollan a través de la inspección, tanto en Mercamadrid como en los establecimientos de hostelería, restauración y comercio minorista de la Ciudad de Madrid, cuyo control se lleva a cabo desde los 21 distritos y los Departamentos de Seguridad Alimentaria, Departamento de Inspección Central, Aguas de Consumo y Transporte Alimentario y Departamento de Inspección de Mercamadrid de Madrid Salud. Cuenta con el apoyo indispensable del Laboratorio de Salud Pública que realiza el control analítico, fisicoquímico, microbiológico y parasitológico de los alimentos, bebidas y aguas que se consumen en la ciudad de Madrid y que se derivan de las actuaciones del "Plan Anual de Inspecciones y Actividades Programadas de Control Oficial de Alimentos".

	Igualmente, en el Laboratorio se lleva a cabo el análisis de sustancias psicotrópicas y estupefacientes aportadas por Policía Municipal.
Salud Ambiental y Control de Vectores y Plagas.	En materia de Salud Ambiental y Control de Vectores y Plagas, Madrid Salud desarrolla las actividades encaminadas a controlar las condiciones medioambientales que afectan a la salud de la ciudadanía, las condiciones de salubridad de las viviendas y las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de establecimientos en los que se ejercen actividades con incidencia en la salud: centros de estética, centros infantiles, instalaciones de aguas recreativas, etc. Además, cada año, se aprueba el "Plan Anual de Inspecciones y Actividades Programadas en establecimientos con incidencia en la salud pública" Desde el año 2010, el Departamento de Salud Ambiental de Madrid Salud, colabora activamente en el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid, formando parte del Sistema de Vigilancia Sanitaria de Riesgos Ambientales y el Sistema de Alertas en Salud Ambiental ante episodios de contaminación atmosférica y episodios de temperaturas extremas. Madrid Salud, además gestiona los peligros y riesgos asociados a la presencia de plagas vectores de la ciudad, y en edificios e instalaciones municipales (cucarachas, ratas, chinches, etc.) a través del Departamento de Control de Vectores
Promoción de la salud y bienestar animal.	En materia de promoción de la salud y el bienestar animal, Madrid Salud, a través del Centro de Protección Animal (CPA), desarrolla actuaciones encaminadas a actuar sobre las poblaciones de animales domésticos atendiendo a su salud y bienestar animal para minimizar su impacto en la salud pública, concepto conocido como "one health", mediante cuatro objetivos claramente definidos: • Prevenir y controlar la aparición de problemas para la salud y la seguridad derivados de la presencia de animales. Acogida de animales vagabundos y abandonados • Fomentar la protección y bienestar de los animales en la Ciudad. Plan de Esterilización de Animales de Compañía y fomento de la adopción. • Mejorar la sostenibilidad en relación con la presencia de animales en la ciudad. Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. • Control sanitario de las poblaciones de gatos urbanos en la ciudad.

2.3.- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.

El Ayuntamiento de Madrid no tiene competencias asistenciales. Esta competencia viene recogida en el Art. 137 de la LOSCAM y en el Art.25.2 h, c y d de la Ley General de Sanidad. Los objetivos principales son:

- La salud pública municipal mantendrá su compromiso y contribuirá, junto con otras instituciones o colectivos, a promover la salud de los y las madrileñas y la prevención de sus principales problemas de salud, desde la detección precoz, la intervención grupal e individual, el desarrollo de la salud comunitaria, y las actuaciones en situación de crisis sanitaria.

- Promoverá y sensibilizará sobre la presencia de la salud como un factor relevante a tener en cuenta en las políticas municipales y se esforzará para aportar su perspectiva en aquellos foros, comisiones o grupos de trabajo en donde esté integrada.

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con los **Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc)**, son los responsables de desarrollar esta estrategia en los 21 distritos de la ciudad de Madrid. El liderazgo en el territorio es una estrategia central de su trabajo. Por lo que toda la estructura organizativa se concibe para apoyar el trabajo de los CMSc.

Los Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc) **son centros municipales especializados en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades y otros problemas de salud.** Por lo tanto, su objetivo no es tratar la enfermedad (algo que ya hacen los centros de atención primaria o especializada), sino que se centran en prevenirla y en ayudar a las personas, los grupos y las comunidades a conseguir estilos y condiciones de vida saludables.

El **Ayuntamiento de Madrid** pone al servicio de los madrileños una red de CMSc y de centros monográficos especializados, repartidos por la ciudad, dotados de una plantilla multidisciplinar formada por profesionales de la medicina, especialistas en ginecología, psiquiatría, pediatría, psicología o enfermería, además de trabajo social, auxiliares de salud y administración.

Estos Centros actúan:

- Mediante la promoción de estilos, modos y condiciones de vida saludables.
- Mediante la educación para la salud a la población.
- Mediante actividades preventivas sobre los problemas de salud más prevalentes.
- Abordando los malestares que produce la vida cotidiana.
- Reforzando a la comunidad para enfrentarse de manera autónoma a los problemas del barrio.
- Eliminando las barreras socioculturales de edad, género, clase social, etnia e identidades sexuales.
- Dando atención prioritaria a las zonas y grupos sociales con mayores necesidades de salud.
- Implicándose en los espacios de encuentro, con coordinación y alianzas institucionales y con las redes sociales del distrito
- Fomentando y apoyando diversas fórmulas de cuidado individual y colectivo.

El trabajo se realiza tanto dentro del propio centro como en la comunidad, a través de:

- Atención individual.
- Actividades grupales.
- Actividades comunitarias en el barrio, (espacios públicos y de encuentro, centros educativos, deportivos y culturales, centros juveniles y de personas mayores, asociaciones vecinales, ONGs, etc.).

A estos Centros puede acudir cualquier persona que viva, estudie o trabaje en el distrito: la ciudadanía, así como organizaciones, asociaciones o colectivos interesados en mejorar la calidad de vida y la salud del distrito.

Los CMSc constituyen espacios abiertos a todas las colaboraciones cuyo objetivo sea hacer de Madrid una ciudad más saludable y ayudar a su ciudadanía a promover la salud comunitaria y la equidad en salud.

2.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Las actuaciones de la Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales son las establecidas en la **Ley 31/95** y su desarrollo reglamentario, donde se recogen los **principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de las y los trabajadores en materia preventiva**, lo que significa:

- Evaluación del Riesgo de Personas trabajando y de Edificios.
- Vigilancia de la salud de las/los empleados públicos.

Mediante el desarrollo de las siguientes **funciones**:

- El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la empresa.
- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los y las trabajadoras en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
- La información y formación de los trabajadores, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
- La vigilancia de la salud de las y los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
- La realización de reconocimientos médicos ginecológicos a la mujer con objeto de descartar una posible patología.
- Reconocimientos médicos encaminados a posibilitar una adecuada adaptación del puesto de trabajo a las características individuales de la persona o proponer la movilidad de ese empleado/a municipal a otro puesto de trabajo que respete esas características.
- Colaboración con las autoridades sanitarias para proveer el Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral.
- Cualquier otra función orientada a una mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de las y los trabajadores municipales.

La estrategia de la prevención de riesgos se desarrolla a través de las Unidades Técnicas, adaptadas al modelo establecido en la normativa vigente: Higiene Industrial, Seguridad Laboral y Ergonomía y Psicosociología. Y a través del Departamento de Salud Laboral, **Instituto Fabiola de Mora y Aragón.**

3.- ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: MADRID, UNA CIUDAD SALUDABLE, 2.021-2.024.

La nueva **estrategia de Prevención y Promoción de la Salud, Madrid, una Ciudad Saludable 2021- 2204** (en adelante **Madrid, una ciudad saludable**) define el conjunto de actuaciones municipales orientadas a prevenir la enfermedad y promocionar la salud en la ciudad de Madrid. Recoge la experiencia de las dos estrategias anteriores, Gente Saludable 2010-2015 y Barrios Saludables 2016-2019 y del Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, así como los aprendizajes obtenidos de las evaluaciones realizadas.

La actual estrategia se rige por los principios y metodologías propias de la **prevención y promoción de la salud comunitaria**, siendo su objetivo final **aumentar la capacidad de las personas y de las comunidades para incrementar su control sobre los determinantes de la salud** y, en consecuencia, mejorarla. Todo ello, dentro del marco de las competencias atribuidas a Madrid Salud.

La presentación de esta nueva estrategia estaba prevista en la primavera de 2020. La irrupción de la crisis sanitaria ha motivado su adaptación a la actual situación, tal y como se recoge en la medida MS.GT4.018/141 "Revisión de la estrategia Madrid, una ciudad saludable, de Madrid Salud y de los CMSc, en enero de 2021, valorando la situación del momento y a la luz de la evolución de la pandemia". Esta revisión se centra en una profundización de la orientación en Salud Pública como eje central de todas las actuaciones, tanto en las relacionadas directamente con el coronavirus y sus consecuencias en salud, como el resto de las actuaciones de promoción de la salud. Esta situación ha puesto en valor actuaciones que ya estaban en la génesis de prevención y promoción de la salud como es la orientación y asesoramiento en salud pública y la creación de nuevos servicios y actuaciones.

Prevenir y contener el contagio ha sido y es la prioridad para esta estrategia. No obstante, es imprescindible mantener la atención al resto de las necesidades en salud. Por este motivo, aún en las excepcionales condiciones marcadas durante el primer estado de alarma, se ha mantenido la atención presencial a la ciudadanía desde los Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc) y los Centros Específicos (CE), atención que se ha visto reforzada creando alternativas para facilitar la atención telemática a la población madrileña.

Las circunstancias que rodean a la pandemia condicionan los hábitos saludables (alimentación, ejercicio, contacto social…) por lo que los programas marco han revisado sus objetivos, metodología y actuaciones a esta situación de crisis sanitaria. La COVID 19 ha **acrecentado las desigualdades en salud** de la población madrileña y éstas influirán durante largo tiempo una vez finalizada esta situación. Por tanto, Madrid, una ciudad saludable profundiza en su orientación en salud pública y en la atención a los determinantes sociales en salud con el objetivo de fomentar la equidad en salud.

Madrid, una ciudad saludable incluye otras novedades. Escalará a nivel de ciudad los proyectos piloto iniciados en 2018 en determinados barrios de la ciudad, **Prevención de la Soledad No Deseada y Comunidades Compasivas**, que se desarrollarán en todos los distritos de la ciudad. Asimismo, se prevé la incorporación de nuevas líneas de actuación, como la **prevención del suicidio**. Promover la salud implica identificar los principales problemas de salud de la ciudad, las estrategias más adecuadas para su abordaje y las poblaciones de intervención prioritaria. Requiere trabajar en el territorio y en colaboración con otras instituciones públicas, entidades sociales y ciudadanas para identificar, promover y desarrollar los activos en salud en el entorno cercano a las personas y en su vida cotidiana. Con este fin, Madrid, una ciudad saludable organiza sus actuaciones en proyectos estratégicos y programas marco para el abordaje de los retos de salud de la ciudad y en proyectos de centro adaptan los anteriores a las necesidades de sus territorios de influencia.

3.1.- MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESTRATEGIA MADRID, UNA CIUDAD SALUDABLE.

MISIÓN.	• Desarrollar **actuaciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad** en la ciudad de Madrid, en colaboración con organismos y entidades, **promoviendo la participación de las personas para aumentar su autonomía y su corresponsabilidad en su salud.** • Ser una **red de centros de referencia y liderazgo en la promoción de espacios de encuentro y coordinación intersectorial en salud**, promoviendo la colaboración con Salud Pública de la Comunidad de Madrid (CM). • Establecer una **relación sólida con las redes sociales del distrito para la salud y cohesión de los barrios y ser proactivos para afrontar momentos de crisis sanitarias**.
VISIÓN.	Promover una ciudad en la cual las personas mantengan un **alto nivel de salud y bienestar potenciando su participación y corresponsabilidad en la consecución de esta situación.**

3.2.- PRINCIPIOS RECTORES Y CRITERIOS METODOLÓGICOS.

PRINCIPIOS RECTORES.

Las actuaciones realizadas en el marco de la presente estrategia se orientan por los siguientes principios rectores:

Equidad en salud.	Actuar, directa o indirectamente, sobre los determinantes sociales de la salud con el fin de reducir la carga de enfermedad y las desigualdades sociales en salud en una población. De esta manera, se siguen las recomendaciones de la OMS y de la Comisión Europea que señalan la prevención y la promoción de la salud como herramienta fundamental para reducir la inequidad social en salud.
Universalismo proporcional.	Priorización de los territorios y colectivos más vulnerables o con necesidades especiales, sin dejar por ello de atender a la población general con el fin de conseguir el máximo potencial de salud de cada persona.
Intersectorialidad.	En el ámbito municipal, se propone que la salud continúe siendo un eje transversal al resto de políticas municipales, mediante la facilitación de información sobre la situación de salud de la población madrileña y la coordinación y colaboración con otras Áreas de Gobierno, como por ejemplo, Familia, Igualdad y Bienestar Social, Cultura y Deporte o con las Juntas de Distrito. Madrid Salud colaborará en todos los foros, comisiones técnicas y grupos de trabajo que permitan visibilizar la perspectiva municipal en el ámbito de prevención y promoción de la salud e influir en otras políticas relacionadas con la salud.

Enfoque integral y ecológico.	Implica considerar las necesidades de salud desde una perspectiva física, psicológica y social que tenga en cuenta los factores individuales, familiares, interpersonales, organizacionales y comunitarios en los que se suceden los problemas de salud, así como los relacionados con las políticas públicas, todo ello, con perspectiva de género.
Participación.	Los procesos de toma de decisiones deben tener como centro a las personas y su implicación en las actuaciones de salud. La participación es esencial para fortalecer la sostenibilidad de las intervenciones y asegurar que responden a las necesidades reales de la población. La participación es un medio y un instrumento necesario para abordar los problemas de la salud y adquirir una mayor capacidad de intervención sobre los determinantes sociales de la salud. Por tanto, la participación en salud no debe centrarse en los servicios sanitarios, sino abarcar otros sectores y condiciones sociales directamente relacionadas con el estado de salud de la población y sus condiciones de vida.
Compromiso ético.	Respeto a los derechos humanos, defendiendo que todas las actuaciones tengan en cuenta los principios éticos de humanidad, autonomía, justicia e inocuidad.

CRITERIOS METODOLÓGICOS.

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en la ciudad de Madrid se desarrollan en un entorno complejo, diverso y multicultural. La extensión y número de habitantes de Madrid requiere de un trabajo de adaptación y detección de necesidades en los distintos territorios conformados en distritos y barrios. La red de centros de prevención y promoción de la salud desarrollan los programas marco y proyectos definidos de esta estrategia que definen las actuaciones a seguir atendiendo a los criterios metodológicos siguientes:

Orientación comunitaria.	Implica partir de una visión integral de las personas, biopsico-social, en la cual es necesario tener en cuenta las variables individuales y sociales. Este enfoque posibilita no solo entender las necesidades concretas de salud de las personas, sino también, todas las circunstancias que suceden alrededor de los problemas de salud (condiciones de vida, empleo, vivienda, momento del ciclo vital…). Esta perspectiva orienta las actuaciones individuales y grupales que se realizan desde los CMSc y también, las que se realizan en el ámbito comunitario, permitiendo así desarrollar vínculos y el abordaje de las necesidades comunes.
Atención a los determinantes sociales de salud.	Para abordar los factores personales, sociales, económicos y ambientales potencialmente modificables que determinan el estado de salud de las personas y de las poblaciones. En la Carta de Ottawa para la promoción de la salud (1986) ya se ponía de manifiesto la importancia de una acción concreta y eficaz de la comunidad para establecer las prioridades de salud, la adopción de decisiones y la planificación de estrategias y su implementación con el fin de mejorar la salud.
Enfoque salutogénico.	Mediante el cual el foco se centra en los elementos o factores que ayudan a mejorar la salud, incluso, ante la exposición de factores patógenos. Implica detectar y potenciar las fuentes de salud (activos en salud) en cada distrito, colectivo o persona, en contraste al enfoque patogénico, centrado en el origen de la enfermedad. El enfoque salutogénico permite a los CMSc trabajar sobre la vida cotidiana y en los ámbitos públicos en los que ésta ocurre (plazas, parques, mercados, las fiestas, patios de recreo de los colegios, lugares de trabajo, centros de mayores, etc.) mediante la metodología de "Mapeo de Activos en Salud".

Mapeo de activos en salud.	Metodología para la identificación de los activos de salud de cada barrio. Los mapas de activos en salud se construyen con la participación de la comunidad en jornadas en las cuales la ciudadanía marca los espacios que en su entorno son fuente de bienestar en su vida cotidiana. Tiene como objetivo fortalecer las relaciones sociales existentes y construir otras nuevas, con el fin promover el desarrollo comunitario y mejoras en el entorno con la participación de la ciudadanía.
El trabajo en equipo, interprofesional e interdisciplinar.	Los CMSc se componen de equipos interprofesionales (medicina, enfermería, ginecología, pediatría, psicología, trabajo social y personal auxiliar sanitario y administrativo) El trabajo en equipo es una pieza clave para el trabajo de nuestros centros, ya que es necesario un enfoque metodológico adecuado para que el conjunto de saberes presentes en un equipo pueda tributar a una mejora de la salud de la población. Asimismo, las herramientas metodológicas del trabajo en equipo son también necesarias para el trabajo en la comunidad y la coordinación con los diferentes actores del distrito.
Eliminación de las barreras sociales y culturales.	Para facilitar la atención a las zonas y los grupos sociales con mayores necesidades de salud, identificadas en el trabajo cotidiano en el distrito. Se han definido los criterios para definir un territorio como Zona de Intervención Preferente (ZIP) así como las variables sociales a consignar en el sistema de información para cada actuación.
Intervención individual y grupal.	Los centros facilitan asistencia individual cuando las circunstancias de salud de la persona así lo aconsejan. Asimismo, se diseñan y actualizan las actividades grupales orientadas a los objetivos de salud marcados por la presente estrategia. Estas actividades grupales, además, podrán constituir puntos de encuentro en los que se promoverán las relaciones interpersonales para prevenir la soledad no deseada. Las actuaciones individuales y grupales tendrán una orientación integral y comunitaria, según lo expuesto en el punto uno de este apartado.
Proyectos de Centro.	El trabajo a través de Proyectos de Centro de cada CMSc con el fin de adecuar las líneas estratégicas y de actuación a las necesidades y características de la población de los distintos territorios de la ciudad, tal como se expondrá en apartados siguientes.
Evidencia.	Las recomendaciones e intervenciones propuestas serán respaldadas por la evidencia, a través de análisis y evaluación de resultados.
Evaluación.	Asegurar la evaluación del proceso, resultados e impacto de las intervenciones, así como de la difusión de resultados y transparencia del proceso.

3.3.- OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS OPERATIVOS.

Objetivos generales.	• Contribuir, junto con otras instituciones o colectivos, a promover la salud de la población madrileña y a la prevención de sus principales problemas de salud desde la detección precoz, la intervención individual, grupal y el desarrollo de la salud comunitaria. • Promover y sensibilizar sobre la presencia de la salud como un factor relevante a tener en cuenta en las políticas municipales y aportar su perspectiva en aquellos foros, comisiones o grupos de trabajo en donde esté integrada.

Objetivos operativos.	• Mejorar las condiciones de salud en la población a través de una asesoría en salud pública y promoción de la salud a dispositivos y recursos municipales y externos, tanto centralizados como en el territorio. • Fomentar una sociedad en red donde las personas se vinculen y se favorezca la salud y el bienestar para prevenir la soledad no deseada y prevenir el duelo complicado. • Contribuir a la equidad en salud en la ciudad de Madrid, a través del impulso de participación de la población, haciendo especial hincapié en aquellas personas y colectivos que viven en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social. • Fomentar hábitos saludables en la población de la ciudad de Madrid, especialmente, la alimentación sana y la actividad física regular. • Contribuir a la vivencia sana y placentera de las diversas sexualidades de las personas en la ciudad de Madrid. • Disminuir la prevalencia y fomentar el abandono del consumo de tabaco. • Promocionar la salud mental y el bienestar emocional en la ciudad de Madrid, potenciando las capacidades de las personas y su entorno para conseguir el mejor desarrollo personal, social y comunitario. • Velar por el adecuado desarrollo del menor durante el proceso de crianza, incluida la etapa preconcepcional, y fomentar su salud y de quienes le cuidan. • Apoyar a la comunidad escolar educativa en las actuaciones de prevención y promoción y de la salud desde un enfoque integral y positivo, basado en la coordinación con los recursos sociosanitarios y educativos del distrito. • Mejorar la calidad de vida de la población mayor para contribuir a ampliar la esperanza de vida activa y saludable y retrasar la discapacidad y la dependencia.

3.4.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN.

La **orientación en salud pública** se perfila como línea de actuación principal que orienta todas las actuaciones de esta estrategia para prevenir la enfermedad y promocionar la salud. En situaciones de crisis sanitarias, provee de los recursos y servicios precisos para hacer frente a las nuevas necesidades provocadas por situaciones epidemiológicas excepcionales y adapta los existentes con el fin de garantizar la continuidad de los servicios municipales en materia de prevención y promoción de la salud.

Los **proyectos estratégicos** hacen referencia a nuevas necesidades de salud detectadas en la población. El Proyecto estratégico para la prevención de la soledad no deseada, que incluye el proyecto de Comunidades Compasivas para la prevención del duelo complicado, se iniciaron como proyectos piloto en determinados barrios de Madrid en el marco del Plan Madrid Ciudad de los Cuidados y, ahora, se consolidan como proyecto a nivel de toda la ciudad.

Los **programas marco** incluirán los objetivos de estos proyectos estratégicos con un enfoque transversal. Los programas marco son las áreas de trabajo que se organizan para el abordaje de los problemas y oportunidades de salud consideradas tradicionalmente prioritarias y que ya hacían parte de las anteriores estrategias. Entre los programas marco podemos diferenciar:

Programas transversales.	• Desigualdades sociales en salud, que aporta al resto de programas las herramientas metodológicas necesarias para lograr la equidad en salud y la aplicación del universalismo proporcional. • Promoción de la salud mental que contribuye facilitando al resto de programas las claves para impulsar y mantener hábitos saludables.
Programas orientados a áreas concretas de salud.	• Alimentación y actividad física • Prevención del tabaquismo • Salud sexual y reproductiva
Programas destinados a promocionar la salud en determinados ciclos vitales.	• Materno infantil • Ámbito educativo • Envejecimiento activo y saludable

Los **proyectos de centro** son el compromiso de trabajo y la definición de las prioridades establecidas por cada CMSc, en función de los problemas, oportunidades y necesidades específicas de salud de la población de sus territorios a partir de los programas marco y proyectos estratégicos.

Las líneas de actuación de la presente estrategia se definen a partir de las necesidades de salud detectadas en la población madrileña. La tabla siguiente resume como se perfilan los retos a atender mediante proyectos y programas, a partir de las necesidades detectadas:

PROBLEMAS DE SALUD **(Estudio Salud Ciudad de Madrid 2.018).**	**RETOS / OBJETIVOS OPERATIVOS.**	**LÍNEAS DE ACTUACIÓN.**
La pandemia por coronavirus hace imprescindible orientar las actuaciones a la prevención del contagio y a los problemas de salud.	Mejorar las condiciones de salud pública en la población a través de una asesoría en salud pública y promoción de la salud a dispositivos y recursos municipales y externos, tanto centralizados como en el territorio.	**ORIENTACIÓN EN LA SALUD PÚBLICA EN TODAS LAS ACTUACIONES**
En la ciudad de Madrid, el 10% de las personas encuestadas se sienten solas. En el 30,7% de los hogares madrileños vive una sola persona.	Mejorar el bienestar de las personas en situación de soledad no deseada, a través del fortalecimiento de las redes de apoyo.	**PROYECTO ESTRATEGICO DE SOLEDAD NO DESEADA. COMUNIDADES COMPASIVAS**

El 43,5% de las personas desarrolla un trabajo donde no realiza actividad física y el 30,2% tiene hábitos sedentarios en su tiempo libre. El 12,5% de la población madrileña consume 5 raciones de vegetales al día. Casi el 47% de personas mayores de 18 años tiene exceso de peso.	Fomentar hábitos saludables en la población de la ciudad de Madrid, favoreciendo la alimentación sana y la actividad física regular. Se propone conseguirlo actuando desde una doble estrategia, poblacional y de alto riesgo.	**PROGRAMA MARCO ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD (ALAS)**
Tendencia ascendente de la incidencia de la infección gonocócica en la ciudad. La cifra de nuevos casos de infección por VIH, detectados en los últimos años se mantiene en descenso.	Contribuir a la vivencia sana y placentera de las diversas sexualidades de las personas en la ciudad de Madrid.	**PROGRAMA MARCO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**
El 19% de jóvenes de 15 años declara fumar diariamente. En el conjunto de la población el porcentaje asciende al 22,5%.	Disminuir la prevalencia del consumo de tabaco entre la población de la ciudad de Madrid.	**PROGRAMA MARCO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CONSUMO DE TABACO**
En 2018, el INE registró 1878 hogares monoparentales de los que 81,9% están constituidos por mujeres.	Contribuir a elevar el nivel de salud de aquellas personas que se planteen la maternidad/paternidad, personas embarazadas, el futuro bebé en los primeros años de vida y el entorno socio-familiar a través de actividades preventivas y de promoción.	**PROGRAMA MARCO SALUD MATERNO INFANTIL**
El 57,8% de los mayores de 65 años estaría en riesgo de dependencia, situación que aumenta con la edad. El 20% de mayores de 65 años refiere quejas de memoria.	Contribuir a ampliar la esperanza de vida activa y saludable, mejorando la calidad de vida de la población mayor de la ciudad de Madrid, contribuyendo a retrasar lo más posible la discapacidad y la dependencia.	**PROGRAMA MARCO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE**
En la población de 3 a 12 años, la prevalencia de sobrepeso alcanza el 40,9%, porcentaje que puede verse incrementado en determinadas zonas vulnerables de la ciudad.	Apoyar a la comunidad escolar educativa en las actuaciones de Prevención y Promoción y de la Salud desde un enfoque integral y positivo, basado en la coordinación con los recursos socio-sanitarios y educativos del distrito y en la utilización de espacios.	**PROGRAMA MARCO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO**

El 21% de las personas encuestadas presenta riesgo de mala salud mental.	Promocionar la salud mental y el bienestar emocional en la ciudad de Madrid, potenciando las capacidades, sentimientos, vínculos, acciones y entornos adecuados para conseguir el mejor desarrollo personal, social y comunitario.	**PROGRAMA MARCO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL**
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) fue del 26% en 2017. El índice de Gini (desigualdad / ingresos económ.) mayor que el de España: 35,6% y 34,1%.	Contribuir a la equidad en salud en la ciudad de Madrid, fomentando la participación de la población, haciendo especial hincapié en aquellas personas y colectivos que viven en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social.	**PROGRAMA MARCO DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD**
Problemas de salud detectados en un territorio concreto.	Adaptación de los objetivos y actuaciones de salud a la población de un territorio específico.	**PROYECTOS DE CENTRO**

3.4.1.- ORIENTACIÓN EN SALUD PÚBLICA.

OBJETIVO GENERAL.
Apoyar como referentes en prevención y promoción de la salud de la ciudad de Madrid y dar respuesta a la población y a las instituciones, fundamentalmente municipales, en relación con la prevención y promoción de la salud en general y, específicamente, en situaciones crisis epidemiológicas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
• Prevenir y romper la cadena de contagio en crisis epidemiológicas. • Atender las necesidades de salud provocadas directa e indirectamente por crisis sanitarias. • Mantener la atención a las necesidades existentes en salud habituales en la población.
OBJETIVOS OPERATIVOS.
Para cumplir con los objetivos anteriormente descritos, es necesario realizar tanto adaptaciones de los servicios habitualmente prestados como la implantación de otros nuevos en función de las necesidades determinadas por las crisis sanitarias: A. Crear nuevos servicios que contribuyan a la prevención y contención del contagio, así como para la atención las nuevas necesidades en salud. B. Mantener la actividad de los centros como referentes en promoción de la salud. C. Adaptar los proyectos estratégicos y programas marco para mantener sus objetivos de salud durante la pandemia y prevenir las desigualdades en salud. D. Colaboración con otras administraciones y entidades.

3.4.2.- PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA.

FUNDAMENTACIÓN.

Diferentes estudios científicos confirman que la ausencia de vínculos personales incrementa los riesgos para la salud física, psíquica y, más en general, la calidad de vida de las personas (S. Cacioppo et al. 2015).

Entre dichos riesgos, podemos destacar los siguientes:

• Riesgos en la salud física: problemas cardiovasculares, descenso del sistema inmune, incremento del riesgo de mortalidad prematura.

• Riesgos en la salud psíquica: ansiedad, depresión, deterioro cognitivo y, en sus formas más severas, ideación suicida.

• Empeoramiento de hábitos saludables: sedentarismo, tabaquismo, mala alimentación, peor calidad del sueño.

• En personas mayores se produce mayor riesgo de caídas, más reingresos hospitalarios, más institucionalización y más atención domiciliaria. Por tanto, la soledad es un problema de salud pública con incidencia creciente con repercusión sobre la salud física y mental de las personas. Es por ello preciso realizar actuaciones preventivas y de promoción orientadas a facilitar el encuentro y la creación de vínculos interpersonales en los barrios ya que este abordaje:

• Alivia el sufrimiento y mejora la calidad de vida de las personas.

• Implica un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, trabajando con las organizaciones y comunidades locales para desarrollar las capacidades existentes.

• Tiene un elevado retorno social: ahorro en servicios de atención y tratamiento de los problemas de salud derivados que se pueden prevenir con una moderada inversión en recursos sociosanitarios con enfoque comunitario. Según el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, un 10,2% de las personas encuestadas manifestaron sentirse solas siempre, casi siempre o bastantes veces durante el último año. La soledad no deseada se vive con un especial sufrimiento tras la pérdida de un ser querido. De ahí la importancia que adquiere el proyecto Comunidades Compasivas, especialmente, en la situación sanitaria actual.

OBJETIVO GENERAL.

Fomentar una sociedad en red donde las personas se vinculen y se favorezca la salud y el bienestar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Sensibilizar a la ciudadanía en materia de soledad no deseada para promover actitudes empáticas y de corresponsabilidad que contribuyan a desestigmatizar la soledad y a fortalecer los vínculos interpersonales.

• Fortalecer la capacidad de los centros de la Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud para identificar, impulsar y crear actividades que fomenten el encuentro interpersonal:

- Colaborar con los colectivos sociales ya existentes y sus redes para sensibilizar y prevenir la soledad no deseada.
- Favorecer que las actuaciones grupales y comunitarias realizadas por otros programas constituyan espacios de encuentro interpersonal.
- Promover la activación de grupos y colectivos que faciliten la conexión entre personas y la creación de vínculos interpersonales.
- Vincular al proyecto actuaciones de recursos públicos y privados de los distritos que puedan suponer oportunidades de encuentro interpersonal para la población madrileña.

- Generar canales que contribuyan a vincular a las personas al proyecto. • Desarrollar itinerarios de actuación adecuados a los diferentes territorios y situaciones de riesgo, que permitan dar respuesta a las personas identificadas con sentimientos de soledad o en riesgo de padecerla.
POBLACIÓN DIANA Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.

Estrategia poblacional.	**Población diana:** conjunto de la población. Información y difusión Investigación Sensibilización Creación, refuerzo y mantenimiento de una red de colaboradores en el proyecto Impulso de espacios de encuentro dentro de los centros y en su entorno
Estrategia de riesgo.	**Población diana:** personas en riesgo, situación o con sentimientos de soledad. Detección y vinculación al proyecto Diseño de itinerarios de actuación (incluye Comunidades Compasivas*)

Comunidades Compasivas.

OBJETIVO GENERAL.
Fortalecer la capacidad de las personas de afrontar las situaciones de duelo y crear una red de solidaridad y apoyo hacia las personas que se encuentran en situación de final de vida o que han sufrido la pérdida de un ser querido.
POBLACIÓN DIANA Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.

Estrategia poblacional.	**Población diana:** conjunto de la población. Actividades grupales para capacitar a la población infanto-juvenil y a sus familiares y al profesorado para afrontar las situaciones de duelo (pedagogía de la muerte).
Estrategia de riesgo.	**Población diana:** familiares de personas en situación de final de vida o en proceso de duelo. Grupos de apoyo al duelo (Comunidades Compasivas). Apoyo y asesoramiento individual.

3.4.3.- PROGRAMA MARCO DE PREVENCIÓN DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.

FUNDAMENTACIÓN.
La organización y estructura social de una población provoca que las posibilidades de alcanzar un buen nivel de salud sean desiguales entre sus habitantes. Los determinantes sociales en salud son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen o se relacionan que provocan un gradiente de salud en una población, por lo que deben ser una prioridad en las actuaciones.

Se trata, por tanto, de diferencias injustas y evitables a las cuales es necesario atender. Una estrategia de promoción de la salud eficaz produce cambios en los determinantes de la salud, tanto en aquellos que las propias personas pueden controlar (como las conductas orientadas a la salud y el uso de los servicios sanitarios), como en aquellos que están fuera de su control directo, como las condiciones sociales, económicas y del entorno.

El programa DSS tiene como fin incorporar la perspectiva de equidad en salud en todas las actuaciones de la estrategia Madrid, una ciudad saludable, con el fin de poder contribuir a disminuir la desigualdad en salud.

OBJETIVO GENERAL.

Contribuir a la equidad en salud en la ciudad de Madrid, facilitando que todas las intervenciones contempladas en los programas marco y los proyectos estratégicos de la citada estrategia incorporen la atención a los determinantes sociales en salud y apliquen el universalismo proporcional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Favorecer que, en el diseño, la implementación y la evaluación de las actividades comunitarias, grupales e individuales contempladas en los programas marco, se incorpore la perspectiva de equidad en salud y se tengan en cuenta los diferentes ejes de desigualdad y su interacción.

• Incorporar el enfoque de universalismo proporcional en todos los programas marco con atención universal a toda la población, priorizando los grupos y los territorios con más necesidades de salud o mayor vulnerabilidad frente a determinados problemas de salud.

• Potenciar las intervenciones intersectoriales, favoreciendo sinergias con nuevas alianzas y manteniendo las existentes.

• Fomentar la participación comunitaria promoviendo el empoderamiento de la ciudadanía.

• Facilitar y promover el acceso a nuestros servicios y a otros recursos sociales, sanitarios y educativos.

• Fomentar la aplicación de la perspectiva de género en todas las actuaciones.

• Facilitar estrategias para prevenir el sentimiento de soledad no deseada y mitigar los efectos de quienes ya la padecen, atendiendo a los ejes de desigualdad.

• Promover la sensibilización sobre las desigualdades sociales en salud y contribuir al aumento de su conocimiento e investigación.

Población diana.

El programa tiene como población diana a toda la ciudadanía de Madrid, con especial hincapié en aquellas personas y colectivos que viven en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social.

3.4.4.- PROGRAMA MARCO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.

FUNDAMENTACIÓN.

Las circunstancias sociales y culturales determinan un estilo de vida que condiciona los comportamientos en la forma de alimentarse, de moverse y, en definitiva, de cuidarse. Según la OMS estamos inmersos en un ambiente obesogénico que dificulta un estilo de vida saludable.

Estos hábitos de vida referidos a la alimentación inadecuada, la escasa realización de actividad física y el sedentarismo están relacionados con la aparición de la obesidad, considerada una epidemia global que tiene grandes repercusiones en la salud de la población al actuar como factor de riesgo común a muchas enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, la hipercolesterolemia, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otras.

El estilo de vida inadecuado, favorecido por el ambiente obesogénico que nos rodea, es generalizado en la población, pero existen situaciones y momentos vitales que pueden generar una mayor dificultar para realizar una vida saludable, situaciones que pueden favorecer una alimentación inadecuada y una mayor tendencia al sedentarismo.

Una de estas condiciones es la soledad no deseada, que supone un problema de salud al asociarse, entre otros factores, a peores hábitos y estilos de vida, a dedicar menos tiempo a cuidarse, a realizar dietas monótonas y poco equilibradas, a ser sedentario en el tiempo libre, a fumar tabaco, a utilizar menos los recursos públicos y a tener menos participación en el barrio. Asimismo, la pandemia y las restricciones que conlleva, alteran la capacidad de adquirir y mantener los hábitos saludables a los que es necesario dar respuesta.

Por estas razones, se considera importante trabajar en la promoción de un estilo de vida saludable para mejorar la calidad de vida de las personas y prevenir la aparición de enfermedades crónicas, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

OBJETIVO GENERAL.

Disminuir la prevalencia de enfermedades no transmisibles relacionadas con los estilos de vida, como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, y mejorar la calidad de vida de toda la población, mediante el fomento de un estilo de vida saludable, a través de la alimentación sana y la actividad física regular.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Promover y facilitar la alimentación saludable.
- Promover y facilitar la práctica de actividad física regular.
- Promover la socialización y el establecimiento de vínculos para lograr mejores estilos de vida.
- Intervenir en personas con sobrepeso-obesidad y/o alto riesgo de diabetes tipo 2.

El programa trabaja con un objetivo transversal que es promover la socialización y el establecimiento de vínculos para lograr mejores estilos de vida, facilitando la participación de la población en todas las actividades comunitarias y grupales que pueden favorecer la consecución de este objetivo.

POBLACIÓN DIANA Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.

El programa ALAS está dirigido a personas de todas las edades que se encuentran en diferentes situaciones vitales y que presentan un riesgo para su salud relacionado con su estilo de vida inadecuado. Se trabaja a través de una estrategia poblacional y una estrategia de alto riesgo, estableciendo alianzas con socios que tienen los mismos objetivos, y realizando acciones para la difusión y extensión del programa para que llegue a una mayor población.

Estrategia poblacional.	**Población diana:** Población general, con especial atención a los colectivos de mayor vulnerabilidad. Actuaciones grupales y comunitarias de promoción y sensibilización de un estilo de vida saludable. Actividades para favorecer el acceso al ejercicio físico y a una dieta equilibrada.
Estrategia de riesgo.	**Población diana:** Personas que ya presentan un riesgo para su salud relacionado con un estilo de vida inadecuado: personas con sobrepeso u obesidad y/o alto riesgo de padecer diabetes tipo 2. Identificación de personas de alto riesgo (test de Findrisk) y derivación a la intervención específica requerida. Atención personalizada. Actuaciones grupales para fomentar la adopción de estilos de vida saludable, la adherencia a la dieta mediterránea, el hábito de práctica de actividad física moderada y, en su caso, propiciar la pérdida de peso.

3.4.5.- PROGRAMA MARCO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

FUNDAMENTACIÓN.
Siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Salud Sexual y Reproductiva implica conseguir un estado de bienestar físico, emocional y social y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia, es decir, disfrutar de una vida sexual y reproductiva satisfactoria y sin riesgos. Desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva (en adelante, SSyR) se recoge el mandato de Naciones Unidas del derecho a todas las personas a desarrollar y disfrutar de su sexualidad sin coerciones ni violencias, de forma libre y responsable. Asimismo, la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Sanidad 2011, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad) expone que, para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales han de ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios, de este modo la salud sexual será el resultado de un contexto que reconoce, respeta y ejerce los derechos sexuales y reproductivos. Por tanto, para que la salud sexual sea atendida de forma sostenida hay que respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. En el marco de la salud integral, la información y la educación en el ámbito sexual se presentan como dos elementos indispensables para que las personas puedan tomar decisiones libres y responsables con relación a su salud sexual y reproductiva.
OBJETIVO GENERAL.
Contribuir a la vivencia sana y placentera de las diversas sexualidades de las personas en la ciudad de Madrid.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
• Sensibilizar sobre la salud sexual y reproductiva con perspectiva de género. • Contribuir a la disminución del retraso diagnóstico en VIH e ITS. • Informar y facilitar el acceso sobre los métodos anticonceptivos más adecuados a las necesidades de cada persona. • Asesorar en las vivencias de las sexualidades. • Identificar estrategias de afrontamiento sobre la soledad no deseada en aquellas personas que en su día a día sufren malestares producidos por una mala vivencia relacionadas con la salud sexual y reproductiva
POBLACIÓN DIANA Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.

Estrategia poblacional.	**Población diana:** Población general, con especial atención a la población menor de 25 años, a la población en situación de vulnerabilidad social y a profesionales del ámbito docente, sanitario y de la mediación social que trabajan con estos colectivos. Actividades en el ámbito comunitario con el fin de modificar actitudes y formas de vida que mejoren la salud de la población a partir de un abordaje integral de la salud sexual y reproductiva incluyendo las posibles situaciones complejas que puedan tener lugar.
Estrategia de riesgo.	**Población diana:** Adolescentes y personas con factores de vulnerabilidad (violenciade género, migrantes, diversidad funcional, etc.). Atención individual y grupal.

3.4.6.- PROGRAMA MARCO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CONSUMO DE TABACO.

FUNDAMENTACIÓN.
La existencia de un programa marco de Prevención y Control del Consumo de Tabaco dentro de la estrategia Madrid, una ciudad saludable se justifica por distintos motivos: • Por el impacto sociosanitario producido por el consumo de tabaco, primera causa aislada y evitable de enfermedad y muerte en nuestro país. • Por un criterio de equidad, que implica la necesidad de priorizar estrategias que faciliten el acceso a los servicios de salud. • Por la existencia de recomendaciones en este sentido por parte de los organismos internacionales competentes, que sitúan los programas de reducción del consumo de tabaco como prioridad de salud pública. • Por la evidencia de coste-efectividad de las intervenciones terapéuticas para dejar de fumar. • Por la disponibilidad de recursos idóneos para que el programa sea acometido (centros de salud municipales donde se ejecuta, recursos humanos adecuados en cantidad y calidad, evidencia de efectividad disponible...).

OBJETIVO GENERAL.

Disminuir la prevalencia del consumo de tabaco entre la población de la ciudad de Madrid.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Prevenir el inicio del consumo de tabaco entre la población adolescente.

• Incrementar la tasa de abandono del hábito de fumar entre la población fumadora que desea dejar este hábito.

• Motivar a las personas fumadoras que no desean dejar de fumar ("precontemplativas") para que tomen la decisión de realizar un intento de abandono.

• En línea con el objetivo de promover hábitos saludables entre las personas en situación de soledad no deseada, promover, cuando proceda, el abandono del consumo de tabaco.

POBLACIÓN DIANA Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.

El programa tiene como población diana a personas adultas fumadoras que vivan o trabajen en la ciudad de Madrid y adolescentes del grupo de edad de inicio en el consumo de tabaco, con prioridad para los grupos identificados como de más difícil acceso a los centros Madrid Salud y las personas en situación de soledad no deseada. Se plantean las siguientes estrategias y actividades para la consecución de los objetivos señalados con una estrategia a nivel individual tanto en el ámbito individual y formativo como a nivel comunitario, en el ámbito de alianzas, sensibilización, formativo, documental y normativo.

Estrategia poblacional.	**Población diana:** Adolescentes del grupo de edad de inicio en el consumo de tabaco. Actividades y talleres en el ámbito educativo orientadas a la prevención del inicio en el consumo: desmitificación del tabaco, habilidades sociales y para la toma de decisiones. Acciones de sensibilización.
Estrategia de riesgo.	**Población diana:** Personas adultas fumadoras que vivan o trabajen en la ciudad de Madrid con prioridad para los grupos identificados como de más difícil acceso. Evaluación pre y post. Atención individual y grupal. Seguimiento.

3.4.7.- PROGRAMA MARCO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL.

FUNDAMENTACIÓN.

Desde sus inicios, el Programa de Promoción de la Salud Mental (en adelante, PSM) ha trabajado para mejorar las relaciones humanas y las condiciones de vida, ya que tienen un alto índice de correlación con la salud mental y con otros aspectos de la salud.

Los objetivos de este programa se han orientado al desarrollo de los recursos personales y habilidades para la vida que permitan afrontar con bienestar las situaciones difíciles, y a la construcción de vínculos y redes de apoyo sociales y comunitarias, implicando a la población como agentes de salud activos que participen en la mejora integral de la sociedad. Se promueve con sus actuaciones el enfoque salutogénico, que pone el foco en las capacidades y oportunidades de salud,

Este programa canalizará su trabajo adaptándolo a la realidad emergente y a las necesidades detectadas emergentes, como por ejemplo, el impacto psicológico de la pandemia, la prevención de la soledad no deseada y el final de la vida y duelo.

Por último, se señala que el PSM tiene una importante dimensión transversal desarrollando y potenciando la vertiente psicológica y social de cada uno de los programas marco de la presente estrategia.

OBJETIVO GENERAL.

Promocionar la salud mental y el bienestar emocional de la población madrileña y la prevención de sus principales problemas de salud mental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Contribuir al establecimiento de hábitos saludables desarrollando los aspectos psicológicos implicados en todos los Programas Marco.

• Sensibilizar sobre la importancia de una vinculación emocional positiva y saludable y orientar para facilitar su adaptación a los distintos momentos del ciclo vital (infancia, adolescencia y juventud, adultez y vejez).

• Potenciar los recursos personales y sociales que permitan afrontar las situaciones difíciles y estresantes de la vida cotidiana, con especial atención a las situaciones de duelo.

• Prevenir la soledad no deseada en todas las edades y fomentar las relaciones basadas en el buen trato, el respeto mutuo, la autonomía y la cooperación.

• Valorar, orientar y ofrecer apoyo psicológico y asesoría en promoción de la salud mental a personas y profesionales.

POBLACIÓN DIANA Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.

Estrategia poblacional.	**Población diana:** Conjunto de la población Actividades comunitarias sobre temáticas propias de salud mental. Aportación de la perspectiva de la salud mental y el bienestar emocional en las actividades de los Proyectos Comunitarios de los CMSc y de otros programas Marco
Estrategia de riesgo.	**Población diana:** Personas en situación de riesgo. Talleres grupales: • Promoción de la salud mental y del bienestar emocional basada en las Habilidades para la vida de la OMS. • Prevención de la soledad no deseada. • Acompañamiento y prevención del duelo complicado. • Prevención de la ansiedad y el estrés Intervenciones individuales de valoración, orientación, apoyo psicológico y asesoría. Intervenciones individuales de valoración, orientación, apoyo psicológico y asesoría.

3.4.8.- PROGRAMA MARCO DE SALUD MATERNO INFANTIL.

FUNDAMENTACIÓN.

La investigación científica avala la influencia que el contexto familiar ejerce en el desarrollo de las personas. Numerosos autores coinciden en afirmar que ser padre o madre representa una responsabilidad que exige disponer de una serie de habilidades y capacidades para el adecuado cuidado y educación de sus hijos e hijas. Las competencias parentales tendentes al buen trato infantil serían aquellas que proporcionan un apego seguro a niños y niñas con sus personas adultas de referencia (padres, madres, cuidadores) siendo decisivo para su adecuado desarrollo integral.

El embarazo y la llegada de un hijo o una hija es una etapa de vulnerabilidad por todo lo que se mueve a nivel personal, familiar y social con el hecho de ser madre o padre. El Programa de Salud Materno Infantil (PMI) contempla de manera prioritaria familias o menores en situación de especial o mayor vulnerabilidad, condicionadas por factores individuales (experiencias previas, soledad, enfermedad, adicciones...), familiares (mono parentalidad, soledad, falta recursos de apoyo, pobreza, exclusión...) o sociales (inmigración, paro, crisis, sistemas de protección social...)

Madrid Salud se adhiere en 2017 a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el cual ha desarrollado un programa de Parentalidad Positiva en la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud que invita a la adhesión de las intervenciones de consejo integral para la salud en la infancia, el embarazo y la lactancia realizada desde atención primaria a los recursos comunitarios, siguiendo la recomendación 19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Desde el PMI se desarrolla en red con otros recursos formales e informales de los territorios para contribuir en el soporte a las necesidades de las familias más vulnerables del distrito.

Desde el programa se aborda de manera conjunta la salud de las figuras parentales y la salud infantil, priorizando a las familias de mayor vulnerabilidad.

OBJETIVO GENERAL.

Favorecer maternidades y paternidades positivas que posibiliten el desarrollo adecuado del menor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Elevar el nivel de salud de las personas que se plantean la maternidad/paternidad antes de la concepción, en el periodo prenatal y perinatal.

• Facilitar el vínculo afectivo entre el niño, la niña y su figura parental.

• Apoyar la crianza positiva en los primeros años de la vida. • Atención integral de los niños, las niñas y sus familias en situación de especial vulnerabilidad y en coordinación con el resto de las instituciones implicadas en su cuidado y seguimiento.

POBLACIÓN DIANA Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.

Estrategia poblacional.	**Población diana:** Figuras parentales y familias desde antes de la concepción, durante el embarazo y período de crianza, dando preferencia a las situaciones de especial vulnerabilidad. Personas, grupos, entidades y profesionales implicados en la atención y el cuidado de las familias que afrontan un período de crianza, así como de los y las menores. Actividades comunitarias sobre la crianza y la promoción de la salud. Promoción de la lactancia materna.

Estrategia de riesgo.	**Población diana:** Niños, niñas y sus familias, en situación de riesgo psicosocial que requieren iniciativas de apoyo y seguimiento especiales. Atención individual a mujeres y/o familias en período preconcepcional, embarazo y posparto. Atención personalizada a niños y niñas y sus familias en situación de vulnerabilidad. Actividades grupales para familias que abordan diversos aspectos de promoción de la salud y prevención durante la gestación y la crianza y la promoción de la parentalidad positiva.

3.4.9.- PROGRAMA MARCO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

FUNDAMENTACIÓN.

El Programa de Prevención y Promoción de la Salud en el Ámbito Educativo (PAE) es una propuesta de acción que pretende apoyar a la comunidad educativa en las actuaciones de prevención y promoción de la salud desde un enfoque integral y positivo, basado en la coordinación con los recursos socio-sanitarios y educativos del distrito y en la utilización de espacios formales y no formales como oportunidad para la equidad, el desarrollo del alumnado y la generación de escuelas y espacios educativos promotores de salud.

OBJETIVO GENERAL.

Apoyar a la comunidad educativa en las actuaciones de prevención y promoción de la salud física, emocional y social de la población adolescente y joven y del conjunto de la comunidad educativa (personal docente y no docente, alumnado, población adolescente y joven y familias).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Favorecer la participación activa de la comunidad escolar en la promoción de la salud.

• Crear espacios de reflexión y búsqueda de activos en salud; detectar recursos y capacidades en las personas, en los grupos y en el entorno e identificar y potenciar los activos que generan resultados sociales y de salud, resultados intermedios de salud y resultados de promoción de la salud.

• Apoyar a las familias y al profesorado en su tarea educativa facilitando la promoción de estilos y hábitos de vida saludable.

• Potenciar las habilidades individuales para el cuidado de la salud, motivando hábitos de conductas que redunden en beneficio, no solamente de su propia salud, sino también de la colectividad donde vive.

• Atender de manera individualizada personas derivadas de las intervenciones en los centros educativos y espacios susceptibles del desarrollo de educación no formal.

• Favorecer la coordinación y el trabajo en equipo con otros recursos e instituciones sociosanitarios y educativas que trabajan con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tanto en espacios formales como no formales, así como la participación en mesas y otros espacios de coordinación estable.

• Favorecer la reducción del impacto de la soledad no deseada en niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados/as, jóvenes que han estado en situación de tutela y colectivos en riesgo de exclusión social. Potenciar el desarrollo de las habilidades individuales y grupales para el cuidado de la salud de este colectivo.

• Estimular la práctica de ejercicio físico en esta población.

• Favorecer la práctica de unos hábitos alimenticios más saludables. • Favorecer la identificación y el desarrollo de habilidades para la vida (empatía, comunicación asertiva, manejo de problemas y conflictos, manejo de tensiones y estrés).
POBLACIÓN DIANA Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.

Estrategia poblacional.	**Población diana:** Profesorado, familias y alumnado con edades comprendidas entre 3 y 18 años. Talleres y actividades grupales enmarcados en el ámbito educativo: • Hábitos saludables • Educación para la afectividad y sexualidades saludables • Prevención de accidentes • Salud bucodental • Prevención de consumo de tabaco. • Desayunos saludables. • Alimentación e higiene corporal • Madrid un Libro Abierto • Piercing y tatuajes • Prevención y control de enfermedades. • Administración de flúor Actividades de información y sensibilización en el patio del recreo de los centros educativos.
Estrategia de riesgo.	**Población diana:** Personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Atención individualizada de la población joven. Consultas y asesorías relacionadas con la adolescencia destinadas a personas de la comunidad educativa.

3.4.10.- PROGRAMA MARCO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.

FUNDAMENTACIÓN.
Este programa se plantea dar respuesta a la realidad de las personas mayores, teniendo presente las características que definen esta etapa vital, los diferentes problemas de salud que aparecen a lo largo de la vida adulta y, también, las fortalezas que hacen posible el desarrollo personal y contribución a la sociedad de la población mayor. Incorpora las líneas de actuación del Plan del Decenio de Envejecimiento Saludable 2020-2030 (OMS), y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), partiendo de la definición de la OMS en 2002 según la cual el envejecimiento activo es el "Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen". Por tanto, para alcanzar estos objetivos es necesario realizar actividades preventivas y de promoción de la salud que favorezcan el mantenimiento de la capacidad funcional en edades avanzadas y dar una respuesta para lograr el desarrollo integral, el bienestar y la calidad de vida a lo largo del ciclo vital.

El envejecimiento es un proceso biológico del organismo caracterizado por múltiples factores que delimitan su marco de intervención. Para entender su complejidad, es necesario tener presente la existencia de diferentes maneras de envejecer, la variabilidad, la plasticidad y capacidad de adaptación de cada persona, así como el balance entre las ganancias y pérdidas y la diferencia que pueda existir entre la evaluación subjetiva de cada persona respecto a los estereotipos sociales.

Por ello, desde el programa se considera necesario dar una respuesta de salud pública que integre el envejecimiento en el curso de vida, con atención a todas las esferas del individuo y teniendo presente la diversidad en esta etapa, orientada a promover la autonomía en la toma de decisiones y la participación de las personas mayores en las cuestiones que afectan a sus vidas.

En este sentido, el programa desarrolla acciones que inciden en la importancia del entorno, el fomento de la participación y la solidaridad intergeneracional para el mantenimiento de sus derechos y promover la modificación de creencias, sentimientos y comportamientos que estigmatizan a la población mayor.

Por último, el programa ha adaptado su estrategia a la situación de crisis sanitaria que ha afectado, especialmente, a la población mayor, más vulnerable ante la enfermedad y ante las consecuencias de las medidas de prevención del contagio que aumentan el riesgo de aislamiento, soledad, problemas de memoria y mantenimiento de hábitos saludables como el ejercicio físico.

OBJETIVO GENERAL.

Contribuir a ampliar la esperanza de vida activa y saludable, mejorando la calidad de vida y disminuyendo la soledad no deseada de las personas mayores de la ciudad de Madrid.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Fomentar la información y difusión del programa.

• Sensibilizar acerca de los principales problemas de las personas mayores.

• Promocionar hábitos saludables entre las personas mayores, el bienestar emocional y el fomento del buen trato.

• Incrementar el bienestar integral de las personas mayores abordando situaciones de riesgo para prevenir la soledad no deseada.

• Impulsar la inclusión y participación de las personas mayores en la vida de su comunidad.

• Identificar a personas en situación de alto riesgo según la definición del programa y diseñar y aplicar protocolos de actuación personalizados.

POBLACIÓN DIANA Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.

Estrategia poblacional.	**Población diana:** Conjunto de la población madrileña mayor de 65 años y personas o colectivos relacionadas con personas mayores. Actividades de promoción de la salud y sensibilización dirigidas a la población general que incluyen a las personas mayores y su perspectiva como parte importante de esta población. Actividades comunitarias para personas mayores de 65 años abordando situaciones específicas de esta edad (caídas, soledad, bienestar emocional...). Actividades grupales específicas del programa o trasversales con el resto de los programas: Alimentación y Ejercicio Físico, Deshabituación Tabáquica, etc.

Estrategia de riesgo.	**Población diana:** Mayores en especial situación de vulnerabilidad. Atención individual guiada por la historia sociosanitaria para la detección de factores de vulnerabilidad, especialmente: • Prevención de la Soledad no deseada. • Prevención de caídas. • Prevención del deterioro cognitivo. • Prevención de la salud mental. • Prevención del Maltrato y Promoción del Buen Trato.

3.5.- MARCO OPERATIVO.

3.5.1.- RED DE CENTROS.

Para la realización de las actuaciones expuestas en los apartados anteriores, la Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud cuenta con:

• **16 Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc):** Chamberí, Arganzuela, Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal, Fuencarral, Hortaleza, Latina, Puente de Vallecas, Salamanca-Retiro, Tetuán, San Blas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde).

• **5 Centros Específicos** o con influencia en toda la ciudad:

- Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo
- Centro de Salud Bucodental
- Centro de Salud Internacional
- Centro de Especialidades Médicas
- Centro Joven

• **3 Centros de Apoyo**:

- Centro de Diagnóstico por Imagen
- Laboratorio de Análisis Clínicos
- Centro de Apoyo a la Seguridad (CAS)

La red de CMSc, dependiente de la Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud de Madrid Salud, tiene como meta conseguir territorios cada vez más saludables, más preparados para afrontar los retos para la salud de la vida cotidiana y más capaces de articular las múltiples fórmulas posibles de cuidado de la salud.

Están formados por un equipo interdisciplinar (medicina, enfermería, ginecología, trabajo social, psicología, educación social, etc.). Sus criterios de actuación son los siguientes:

• Consideración del distrito y el barrio como unidad de análisis y de intervención.
• Atención universal, priorizando las zonas y los grupos sociales con mayores necesidades de salud.

• Eliminación de las barreras de acceso.

• Fomento e implicación en los espacios de encuentro, coordinación y sinergias interinstitucionales, con las redes sociales del distrito y vecindario.

Los CMSc pretenden consolidarse como referentes en sus territorios de la promoción de la salud de Madrid tanto por su conocimiento sobre los problemas de salud y los determinantes sociales existentes en su ámbito territorial, como por sus actuaciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Por la orientación en Salud Pública, pueden constituirse como centros de referencia en formación práctica e investigación aplicada para salubristas y perfiles profesionales sociosanitarios, complementar y apoyar a la red de salud pública de la Comunidad de Madrid en el ámbito de las competencias municipales.

3.5.2.- LOS PROYECTOS DE CENTRO.

Los CMSc son los responsables del desarrollo de la citada estrategia en el territorio. Este trabajo se recoge en el Proyecto de Centro, que consiste en la adaptación de objetivos y actividades de los programas marco y proyectos estratégicos a las necesidades de su territorio de influencia.

El resultado es un plan estructurado de actuación para desarrollar su labor como centro público de prevención y promoción de la salud. La elaboración del Proyecto de Centro implica un compromiso de trabajo con la comunidad y con la institución, pero principalmente, con el propio equipo del centro, ya que mediante un proceso de reflexión del conjunto por parte de un equipo interdisciplinar se trazan las líneas de actuación para atender a las necesidades y oportunidades de salud de los diferentes territorios de la ciudad.

Por tanto, los Proyectos de Centro se elaboran según:

• Las necesidades de la población, contempladas siempre desde la misión que el centro tiene encomendada.
• Las necesidades detectadas por los programas marco y sus propuestas de actuación.

• Las recomendaciones extraídas de la evaluación de los proyectos de centro anteriores.

• Los recursos sociales, sanitarios y educativos del área de influencia del centro y las estrategias y compromisos previos establecidos con ellos.

• Las prioridades establecidas por el equipo a partir de la reflexión sobre los puntos anteriores.

Anualmente, los centros realizan una actualización de las matrices de planificación de las actividades previstas y las metas a alcanzar según las directrices marcadas por los Programas Marco, los proyectos estratégicos y las necesidades del distrito. Esta labor adquiere especial relevancia en el momento actual, ya que la crisis sanitaria exige una priorización clara de los objetivos en salud para cada distrito y la adaptación de la metodología de actuación a las medidas de prevención del contagio.

Asimismo, la atención en las prioridades marcadas por la pandemia, como, por ejemplo, las campañas de vacunación (gripe, meningococo e incluso, COVID 19) exigen que los proyectos y la actividad de los centros sean lo suficientemente flexibles como para dar respuesta a las necesidades de salud más urgente sin dejar de atender el resto de servicios. Los servicios centrales de la SGPPS y los centros específicos y de apoyo trabajan para dotar a los CMSc de los recursos necesarios, así como del conocimiento técnico específico sobre su área de conocimiento.

4.- PAPEL DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD COMUNITARIA.

4.1.- EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO.

El **Trabajo Social** (TS en adelante) como disciplina nace a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el contexto de la reciente aparición de las Ciencias Sociales, que tratan de aportar un análisis científico de la realidad social y descubrir las leyes que rigen los fenómenos sociales.

Para hablar de la historia del **TS en salud** debemos remontarnos a los primeros años del siglo XX y considerar a **Cabot y Richmond**, pioneros del TS hospitalario y representantes de la filantropía protestante en oposición a la caridad católica. Comienza el paso al TS profesional e institucionalizado.

Cabot en 1905, en EEUU, contrata a la primera trabajadora social hospitalaria, surgiendo así una nueva profesión que se ocupaba de complementar el diagnóstico médico con la situación social y económica de los pacientes, a la vez que se encargaba de movilizar recursos en la comunidad para que los enfermos pudiesen realizar el tratamiento. Paulatinamente se van ampliando las funciones del TS abarcando otras como la educación, la investigación y la prevención.

En el campo de la **salud mental** el TS se integra a partir de 1904 a iniciativa de **Adolph Meyer**, quien consideraba que "la locura es un desajuste del conjunto de la personalidad más que una enfermedad del cerebro y que era necesario para el tratamiento una completa información sobre las intervenciones sociales sobre el paciente". Gradualmente se aprecia el valor de las evaluaciones de los trabajadores sociales en la toma de decisiones (tratamiento global) respecto a una persona con enfermedad mental y así el TS se incorpora como parte de los Equipos de Salud Mental.

En **España**, igual que en otros muchos países, fue un médico, el **Doctor Roviralta**, quien impulsó la **creación de la primera escuela de Trabajo Social**, en Barcelona en el año 1932.

El TS en el **ámbito sanitario** se ha definido como: "**La práctica del T. S. que se produce en los hospitales, y otros establecimientos sanitarios con los objetivos de facilitar una buena salud, prevenir la enfermedad y ayudar a los pacientes física o mentalmente enfermos y a sus familias a resolver los problemas sociales y psicológicos relacionados con la enfermedad. Trata también de sensibilizar al resto del personal sanitario sobre los aspectos sociales y psicológicos de la enfermedad**".

La **Guía de organización del Servicio de Trabajo Social del INSALUD** lo define como "La actividad que se ocupa de los aspectos psico-sociales del individuo, a través del estudio, diagnóstico y tratamiento de los factores sociales que concurren en la promoción de la salud y en la aparición de la enfermedad, colaborando en potenciar el carácter social de la medicina".

Amaya Ituarte lo define como "Actividad profesional que implica, de un lado, el diagnóstico social de la persona enferma y el tratamiento individual, familiar y grupal de la problemática social que aparecen en relación con las situaciones de enfermedad, como aportación al diagnóstico global y al plan general de tratamiento. Y, por otra parte, tiene por objeto la investigación y prevención de los factores psico-sociales que inciden en el proceso de salud-enfermedad de los individuos y comunidades en orden a conseguir la promoción de la salud y mejorar la calidad de vida. El desarrollo del T.S. en salud, al igual que en otros ámbitos, debe realizarse respetando los principios profesionales básicos de autonomía, justicia social, aceptación, confidencialidad, actitud exenta de juicios y utilizando las técnicas propias del mismo."

Todas las definiciones ponen de manifiesto la **importancia del estudio, diagnóstico y tratamiento de los aspectos sociales en los procesos de salud-enfermedad** tanto de los individuos como de las colectividades; proceso de intervención que se enmarca en el equipo interdisciplinar de salud (análisis y abordaje integral e integrado de la salud), sin olvidar el **acercamiento a los recursos** y con ello a la comunidad y la **dimensión investigadora y de coordinación.**

Los **objetivos del T. S. sanitario** lógicamente se insertan en los objetivos de la institución de la que forma parte, enfocados desde el punto de vista de las necesidades y los problemas sociales. El trabajo social como disciplina "se dirige hacia aquellas necesidades humanas que surgen de la interrelación personal-social, y también a desarrollar el potencial humano".

En campo de la salud el objeto del trabajo social sanitario viene delimitado por la situación de crisis que genera la pérdida de la salud o el riesgo de perderla. Podríamos decir en palabras de **Teresa Zamanillo** "el **malestar psicosocial**" centrado en el contexto del continuo la salud enfermedad.

La actuación profesional supone un proceso de intervención, en el que:

- Se consideran y atienden las condiciones sociales que dificultan las mejoras en los procesos de salud- enfermedad.
- Se cuenta con la significación que los conflictos y problemas tienen para las personas y grupos (comunidades) y con las capacidades y habilidades de éstos para afrontarlos, no para hurgar como clínico en su pasado con el fin de curar, sino para comprender los elementos que puedan dificultar o facilitar el cambio y, por tanto, ayudar realmente al proceso. (ayudar en los procesos de aceptación, reorganización de la red de cuidadores, intermediario entre el paciente y el sistema sanitario).
- Y, por último, tiene muy presente los recursos de que se dota o puede llegar a dotarse la sociedad.

4.2.- EL PAPEL DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD COMUNITARIA.

La presencia del Trabajador Social en el campo de la salud se justifica por la importancia e incidencia que los **factores psicosociales** tienen en el proceso salud- enfermedad. El Trabajador Social aportará la dimensión social y comunitaria de la salud permitiendo contemplar la atención a la salud de las personas en relación al medio social en que están insertadas. Además, la importancia y complejidad del análisis de los factores sociales y su prevalencia, hacen difícil que los médicos y el personal de enfermería del Equipo puedan resolver por sí solos los problemas que se derivan de aquellos. Así pues, la intervención del Trabajador Social, tiene como objeto, el cuidado integral de la persona, familia, grupo y comunidad, ayudando a promover, mantener y restablecer la salud.

4.2.1.- FUNCIONES GENERALES DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA SALUD.

El trabajador social tendrá funciones comunes al Equipo, dirigidas a garantizar y mejorar el nivel de salud individual y colectiva de la población, aportando la dimensión social de los factores que influyen en la misma.

- Participación en las actuaciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia y rehabilitación de los individuos, familias, grupo y comunidad.
- Detección y captación de individuos y grupos en situación de riesgo socio- sanitario.
- Fomento de la adquisición de conocimientos, actitudes y hábitos para preservar el nivel de salud.

- Promoción de la participación de la comunidad y de su organización para que colabore activamente en un plan de desarrollo orientado a mejorar el nivel de salud.
- Servir de nexo de unión entre el Equipo de Atención Primaria y la comunidad, favoreciendo la coordinación con otros recursos e instituciones sanitarias y no sanitarias. Recoger la demanda de la población.
- Identificación y registro de los recursos y servicios sociales, manteniendo al día el fichero de recursos.
- Información sobre los programas y funcionamiento del Centro, así como el correcto uso del mismo, a la comunidad.

4.2.2.- NIVELES DE INTERVENCIÓN.

El Trabajador Social intervendrá a tres niveles: individual y/o familiar, con grupos y con la comunidad. En los tres niveles desarrollará actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia y rehabilitación.

Atención individual y/o familiar.

Consiste en la atención social directa individual y/o familiar de todos aquellos pacientes con una problemática social o susceptibles de una valoración social derivados, fundamentalmente, por el Equipo de Atención Primaria. La actuación individualizada se puede desarrollar tanto en el Centro de Salud, para lo cual el Trabajador Social cuenta con una consulta propia, como en el domicilio u otras instituciones. Sus objetivos principales son:

- Conocer la situación social del enfermo, y los factores que pueden influir en el desarrollo y tratamiento de la enfermedad.
- Informar y orientar hacia el recurso más adecuado, capacitándolo y motivándolo para la utilización de los mismos teniendo en cuenta las habilidades personales y los recursos internos del propio individuo.
- Ayudar al individuo y/o familia a superar una crisis, capacitándolo para afrontar los problemas que se le presenten.
- Estudiar los aspectos socioculturales, económicos, costumbres, valores, etc. que condicionen la salud del individuo y/o familia.
- Conocer las consecuencias y el trastorno socio- familiar que significa la enfermedad, la rehabilitación y la readaptación de los enfermos.
- Detectar y captar a individuos y/o familias en situación de riesgo sociosanitario.
- Desarrollar actividades de Educación para la Salud.

DERIVACIÓN DE CASOS. Esta puede ser:

- Del Equipo de Atención Primaria: de los pacientes en situación de riesgo vistos en consulta de demanda o programada.
- A demanda del propio paciente.
- Otros profesionales: Trabajadores Sociales, maestros, educadores...
- Familiares, vecinos.
- Captación propia del Trabajador Social a través de la intervención programada.

Atención grupal.

El objetivo del Trabajo Social de grupo, en Atención Primaria, es el de cambiar actitudes de vida a través de experiencias y actividades en común con otros individuos, que sienten que comparten un problema y se unen para mejorar la situación. Aunque en el campo de la salud, el trabajo con grupos no es exclusivo del Trabajador Social, si es este el profesional fundamental en la intervención con grupos, en la formación, en la captación, coordinación del grupo, con el apoyo de los profesionales sanitarios cuando se requiera. Una de las actividades importantes del trabajo con grupos es la formación de "líderes", que pasen a ser elementos activos y pueden participar en actividades de organización de la comunidad.

En Atención Primaria la formación del grupo y la labor que con ellos se lleve a cabo dependerá de la finalidad del mismo. Cada grupo tendrá unos objetivos específicos, distintos entre sí, y desde un punto de vista metodológico, la participación de los profesionales debe ser distinta. Podríamos hacer una clasificación de los grupos, que atendiendo a su finalidad, son frecuentes en Atención Primaria.

Podemos diferenciar varios tipos de grupos en el ámbito sanitario:

Los grupos con fines socioterapéuticos o socioeducativos.

Dirigidos principalmente a que los propios participantes del grupo obtengan un beneficio. Los objetivos suelen ser para modificar hábitos negativos para la salud, educación sanitaria, realizar acciones preventivas... El Trabajador Social toma al grupo como objeto de su atención- intervención y su función, de coordinación en el grupo, es necesaria. Los criterios de organización de grupos por parte del Trabajador Social son múltiples. Algunos grupos son ya parte del programa de un servicio (diabéticos, enuresis,...) o de una categoría de usuarios puede seleccionarse un grupo por criterio de edad (embarazadas adolescentes, etc.). Estos son los grupos más frecuentes objeto de intervención del Trabajador Social.

Los grupos de ayuda mutua.

Ofrecen a sus miembros la posibilidad de apoyo mutuo para conllevar o superar situaciones que les afecten, generalmente, por prolongados períodos de tiempo. Se autoorganizan e independizan de los profesionales. El Trabajador Social hace una labor de impulsor y motivador para la formación e iniciación del grupo para más tarde dejarlo funcionar solo.

Los grupos de acción social.

Su finalidad es conseguir un objetivo social que va más allá del beneficio de los propios individuos que lo constituyen. El Trabajador Social se sitúa "al lado" del grupo e intenta fomentar la capacidad del grupo para autoorganizarse y ser efectivo en sus logros sociales, intenta así mismo descubrir y potenciar líderes que dirijan el grupo. Un ejemplo de grupo que se forma de acción social sería un grupo para solicitar al Ayuntamiento una mejora del sistema de recogida de basura y suministro de contenedores en el barrio

Atención comunitaria.

El Trabajador Social, por su formación es el profesional mejor cualificado del Equipo de Atención Primaria para coordinar y dinamizar las actuaciones en la comunidad. Va a ser puente de unión entre Equipo y la Comunidad, y participará junto con éste en el resto de actividades. El objetivos del trabajo con la comunidad es doble: Por un lado, ayudar a las personas para adquirir la confianza y las habilidades necesarias para resolver sus problemas; y por otro lado, asegurar que se produzcan cambios en el entorno social, que corrijan desigualdades y marginación social. Debemos entender, pues, la comunidad como una estructura de red en la que subsisten subculturas muy variadas, con unos estilos de vida y unos factores medioambientales que determinan el nivel de salud de la población. El Trabajo con la comunidad implica:

- Conocer la comunidad.
- Prevención y promoción.
- Participación comunitaria.
- Educación para la salud.

El Equipo de Salud necesita conocer la población, el medio y los problemas de salud de la comunidad en la que actúa, determinar los grupos de población con mayor riesgo. Es decir, de qué muere y enferma la gente, y qué factores están influyendo, para lo cual elabora el diagnóstico de salud, que nos va a permitir: **identificar los problemas de salud y las necesidades de la comunidad; y detectar los factores de riesgo, estilos de vida incorrectos, problemas medioambientales, etc.**

Conocer la comunidad es básico para iniciar o reorganizar las actuaciones preventivas y de promoción de la salud. Este podría ser el primer eslabón de la participación de la comunidad en la atención a su salud. La comunidad es el verdadero centro de gravedad de la prevención de la enfermedad y de la promoción de la salud.

Así, desde la intervención social se pueden apoyar los siguientes procesos:

Prevención de la enfermedad.

Son las estrategias utilizables para reducir los factores de riesgo de enfermedades específicas, o bien reforzar factores personales que disminuyan la susceptibilidad a la enfermedad.

Promoción de la salud.

La promoción de la salud es el proceso mediante el cual los individuos y la comunidad está en condiciones de ejercer un mayor control sobre los determinantes de la salud y, de este modo, mejorar su estado de salud. No se ocupa sólo de promover el desarrollo de las habilidades personales y la capacidad de la persona para influir sobre los factores que determinan la salud, sino que también influye la intervención sobre el entorno para reforzar tanto aquellos factores que sostiene estilos de vida saludables como para modificar aquellos otros factores que impiden ponerlos en práctica. La promoción de la salud implica trabajar con la gente, no sobre ella; está encaminada hacia las causas de la salud, subraya la dimensión positiva y afecta y debería involucrar a todos los sectores de la Comunidad. La prevención, pues, pretende mantener el estado de salud, y la promoción, potenciarla al máximo; se pueden considerar dos actividades distintas pero complementarias.

Educación para la salud.

Una de las estrategias de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad es la Educación para la Salud (EPS). Educar para la salud supone facilitar el aprendizaje dirigido a conseguir cambios en los comportamientos perjudiciales para la salud o mantener los que son más saludables. La educación para la salud aparece en la Atención Primaria de Salud como un objetivo, un método, una herramienta de trabajo a través de la cual se instrumentalizan los cambios necesarios para mantener o restablecer la salud. La educación para la salud se puede abordar a nivel individual (en consulta), a nivel grupal y comunitario.

Participación comunitaria.

Otro de los elementos claves en los procesos educativos es la participación tanto a nivel individual como colectiva. Entendemos por participación comunitaria el proceso mediante el cual los miembros de la comunidad son sujetos activos dentro del sistema de salud y han de participar en todo el proceso de gestión de su propia salud, responsabilizándose de su propio desarrollo, en lugar de ser meros beneficiarios. El proceso de participación comunitaria debe incluir el conjunto de mecanismos necesarios para:

- Permitir a la población analizar sus propias necesidades y demandas de salud.
- Realizar una planificación descentralizada en la que se refleje en todo momento la opinión de la comunidad.
- Organizar los servicios de salud de acuerdo con los recursos propios de cada lugar.
- Evaluar la ejecución y resultados de todo el proceso de atención, comprobando si se satisfacen o no las necesidades de salud en la propia comunidad.

El Equipo de Atención Primaria puede diseñar o articular mecanismos de participación comunitaria:

- **Formales:** Consejos de Salud, sistema de reclamaciones y sugerencias, etc.
- **Informales:** Contactos con redes sociales, relaciones con asociaciones, etc.



. Estrategia Madrid, una ciudad saludable. 2.021-2.024.
https://transparencia.madrid.es/FWProjects/transparencia/PlanesYMemorias/Planes/MadridSalud/Ficheros/ESTRATEGIA_Madrid_una_ciudad_saludable.pdf

. Constitución Española.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

. Estatutos del Organismo Autónomo Madrid Salud.
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2004_71.pdf?idNormativa=c1367b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&nombreFichero=ANM2004_71&cacheKey=6

. **Información de recursos de la página web de Madrid Salud.**